

Buku Referensi

EVIDENCE-BASED MIDWIFERY PRACTICE

Dalam Pelayanan Maternal Dan Neonatal

Yeni Fitrianingsih • Hutari Puji Astuti • Sarah Fitria
Maesaroh • Novita Br Ginting Munthe



BUKU REFERENSI EVIDENCE-BASED MIDWIFERY PRACTICE DALAM PELAYANAN MATERNAL DAN NEONATAL

Penulis:

Dr. Yeni Fitrianingsih, SST., MKes.

Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Bdn. Sarah Fitria, M.Tr Keb.

Bdn. Maesaroh, S.ST., M.Kes.

Dr. Bd. Novita Br Ginting Munthe, SST., M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi Evidence-Based Midwifery Practice dalam Pelayanan Maternal dan Neonatal

Penulis:

Dr. Yeni Fitrianiingsih, SST., MKes.
Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb.
Bdn. Sarah Fitria, M.Tr Keb.
Bdn. Maesaroh, S.ST., M.Kes.
Dr. Bd. Novita Br Ginting Munthe, SST., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-28-2

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku referensi yang berjudul **Evidence-Based Midwifery Practice dalam Pelayanan Maternal dan Neonatal** ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan, khususnya dalam penerapan praktik kebidanan berbasis bukti pada pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Pelayanan maternal dan neonatal merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat. Dalam praktik kebidanan, bidan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, efektif, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan evidence-based practice menjadi sangat penting agar setiap keputusan klinis yang diambil tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah terbaik, kondisi pasien, serta nilai dan kebutuhan perempuan serta keluarganya.

Buku referensi ini membahas berbagai konsep penting mengenai evidence-based midwifery practice, mulai dari pengertian, prinsip dasar, tahapan penerapan praktik berbasis bukti, pencarian dan penilaian bukti ilmiah, hingga penerapannya dalam pelayanan maternal dan neonatal. Pembahasan juga mencakup peran bidan dalam pengambilan keputusan klinis, peningkatan keselamatan pasien, pencegahan komplikasi, edukasi kesehatan, serta pemberian asuhan yang berpusat pada perempuan dan bayi.

Dalam pelayanan kebidanan modern, penggunaan bukti ilmiah menjadi dasar penting untuk meningkatkan kualitas asuhan. Bidan perlu memiliki kemampuan dalam memahami hasil penelitian, menilai relevansi bukti, serta mengintegrasikannya ke dalam praktik pelayanan. Dengan demikian, asuhan kebidanan yang diberikan dapat lebih tepat, rasional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klinis maupun kondisi sosial budaya masyarakat.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, peneliti, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memahami serta menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti. Buku ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kompetensi bidan dalam memberikan pelayanan maternal dan neonatal yang profesional, humanis, responsif, serta berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi, keluasan pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku referensi **Evidence-Based Midwifery Practice dalam Pelayanan Maternal dan Neonatal** ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu kebidanan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Semoga buku ini menjadi salah satu rujukan yang mendukung terwujudnya pelayanan kebidanan yang berbasis bukti, aman, bermartabat, dan berpusat pada kebutuhan ibu serta bayi baru lahir.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I HIERARKI EVIDENCE DALAM PRAKTIK KEBIDANAN 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Laporan fenomena atau Opini Ahli (<i>Expert Opinion</i>)	2
C. Single Descriptive atau Qualitative Study	3
D. Systematic Review dari Studi Deskriptif & Kualitatif.....	4
E. Case-Control & Cohort Studies	4
F. Cohort and case-control studies	6
G. Randomized Controlled Trials (RCT)	7
H. Systematic Review & Meta-Analysis.....	7
I. Penutup	8
Referensi.....	9

BAB II ADAPTASI GUIDELINE INTERNASIONAL KE KONTEKS INDONESIA11

A. Pendahuluan.....	11
B. Konsep Guideline Internasional.....	11
C. Konteks Sistem Kesehatan Indonesia	13
D. Strategi Adaptasi Guideline	17
E. Implementasi Dalam Praktik Kebidanan.....	17
F. Tantangan Dan Solusi	18
G. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Adaptasi Guideline.....	19
H. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan Guideline.....	21
I. Inovasi Dan Masa Depan Adaptasi Guideline Di Indonesia	22
J. Penutup	24
Referensi.....	25

BAB III IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED MIDWIFERY (EBM) DALAM ANTE NATAL CARE (ANC), INTRA NATAL CARE(INC), DAN POST NATAL CARE (PNC)27

A. Pendahuluan.....	27
---------------------	----

B. Transformasi Standar Asuhan: Dari Praktik Tradisional Ke Berbasis Bukti	28
C. Implementasi Klinis EBM Dalam Deteksi Dini Komplikasi.....	30
D. Aspek Psikososial dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bingkai EBM	32
E. Penutup	33
Referensi.....	34
 BAB IV AUDIT MATERNAL DAN PERBAIKAN MUTU PELAYANAN	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Konsep Dan Dasar Audit Maternal	38
C. Mekanisme Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Dan Respons (AMP-SR).....	40
D. Faktor Penyebab Kematian Maternal dan Perinatal.....	43
E. Peran Audit Maternal Perinatal Surveilans Dan Respons (AMP-SR) Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.....	45
F. Tantangan dan Upaya Penguatan Pelaksanaan AMP-SR.....	48
Referensi.....	49
 BAB V STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA RISET DALAM KEBIDANAN	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Konsep Budaya Riset dalam Kebidanan	52
C. Karakteristik Budaya Riset.....	54
D. Posisi Budaya Riset dalam Kebidanan.....	55
E. Urgensi Budaya Riset Dalam Pelayanan Kebidanan.....	57
F. Strategi Membangun Budaya Riset dalam Kebidanan	58
G. Penutup	61
Referensi.....	63
 PROFIL PENULIS	65

BAB I

HIERARKI EVIDENCE DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

A. Pendahuluan

EBP (*Evidence-Based Practice*) merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi di dalamnya adalah ilmu pengetahuan atau teori yang ada dengan pengalaman dan bukti-bukti nyata yang baik (pasien dan praktisi). EBP dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal serta memaksa untuk berpikir kritis dalam penerapan pelayanan secara bijaksana terhadap pelayanan pasien individu, kelompok atau system.

EBP menyebabkan terjadinya perubahan besar pada literatur, merupakan proses yang panjang dan merupakan aplikasi berdasarkan fakta terbaik untuk pengembangan dan peningkatan pada praktek lapangan. Pencetus dalam penggunaan fakta menjadi pedoman pelaksanaan praktek dalam memutuskan untuk mengintegrasikan keahlian klinikal individu dengan fakta yang terbaik berdasarkan penelitian sistematis. Beberapa ahli telah mendefinisikan EBP dalam kebidanan sebagai: 1. Penggabungan bukti yang diperoleh dari hasil penelitian dan praktek klinis ditambah dengan pilihan dari pasien ke dalam keputusan klinis 2. Penggunaan teori dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian secara teliti, jelas dan bijaksana dalam pembuatan keputusan tentang pemberian asuhan keperawatan pada individu atau sekelompok pasien dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pilihan dari pasien tersebut.

Tingkatan *evidence* disebut juga dengan *hierarchy evidence* yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu evidence dari rentang bukti terbaik sampai dengan bukti yang paling rendah. Tingkatan evidence ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam EBP. Hierarki untuk tingkatan evidence yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Penelitian dan Kualitas (AHRQ), sering digunakan dalam kebidanan. Hierarki dalam penelitian ilmiah terdapat hierarki dari tingkat kepercayaannya yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Di bawah ini mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi : Laporan fenomena atau kejadian-kejadian yang kita temui sehari-hari, Studi kasus, Studi lapangan atau laporan deskriptif, Studi percobaan tanpa penggunaan teknik pengambilan sampel secara acak (random), Studi percobaan yang menggunakan setidaknya ada satu kelompok

pembandingan, dan menggunakan sampel secara acak, *Systemic reviews* untuk kelompok bijak bestari atau meta-analisa yaitu pengkajian berbagai penelitian yang ada dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Adapun level of evidence tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hierarki dalam penerapan Evidence Based

B. Laporan fenomena atau Opini Ahli (*Expert Opinion*)

Dalam bidang kedokteran, laporan kasus adalah laporan rinci tentang gejala, tanda, diagnosis, pengobatan, dan tindak lanjut dari seorang pasien. Laporan kasus dapat berisi profil demografis pasien, tetapi biasanya menggambarkan kejadian yang tidak biasa atau baru. Dalam hierarki *Evidence-Based Practice* (EBP), Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) berada di tingkat paling dasar (Level VII). Ini bukan berarti tidak berguna, namun dianggap memiliki risiko bias yang paling tinggi dibandingkan metode penelitian formal lainnya.

Berikut adalah karakteristik utama dari Pendapat Ahli:

1. Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) merupakan rekomendasi atau pernyataan yang dikeluarkan oleh individu atau komite ahli yang diakui di bidangnya, namun tidak didasarkan pada studi penelitian yang terstruktur secara ketat (seperti RCT atau meta-analisis).
2. Sumber data bisa berasal dari buku teks, laporan konsensus organisasi profesional, atau pengalaman klinis bertahun-tahun dari seorang praktisi senior.
3. Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) digunakan pada:
 - a. Saat belum ada penelitian formal (RCT/Kohort) yang tersedia mengenai topik tertentu (misalnya pada penyakit langka atau teknologi yang sangat baru).

- b. Sebagai pelengkap untuk memberikan perspektif praktis dalam penerapan temuan ilmiah di lapangan.
- 4. Kelemahan Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) sangat subjektif. Opini satu ahli bisa berbeda dengan ahli lainnya, dan seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau tradisi praktik yang mungkin sudah tidak relevan dengan temuan sains terbaru.

C. Single Descriptive atau Qualitative Study

Single descriptive atau *qualitative study* adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang satu fenomena, peristiwa, atau kasus tertentu. Hasilnya berupa deskripsi rinci berbentuk uraian kalimat bermakna, bukan angka statistik. Pendekatan ini sering digunakan untuk menggali konteks secara mendetail (studi kasus).

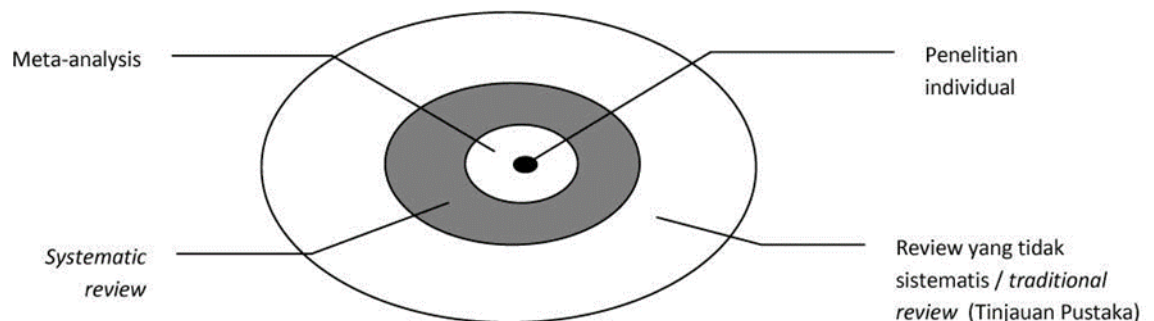
Dalam hierarki *Evidence-Based Practice* (EBP), Studi Deskriptif Tunggal (*Single Descriptive*) atau Studi Kualitatif (*Qualitative Study*) biasanya menempati posisi Level VI. Meskipun berada di tingkat bawah secara statistik, jenis studi ini sangat krusial untuk memahami aspek kemanusiaan dalam kesehatan.

Dalam konteks efektivitas pengobatan, studi ini dianggap "lemah" karena:

1. Tidak Ada Kontrol: Tidak membandingkan dua kelompok (seperti kelompok yang diberi obat vs kelompok plasebo).
2. Subjektivitas: Studi kualitatif sangat bergantung pada interpretasi peneliti dan kejujuran responden.
3. Bukan untuk Generalisasi: Hasil studi kualitatif biasanya hanya berlaku untuk kelompok kecil yang diteliti, bukan untuk seluruh populasi dunia.

Berikut detail mengenai *single descriptive* atau *qualitative study*.

1. Tujuan: Memberikan gambaran komprehensif, terinci, dan mendalam mengenai subjek penelitian (individu, kelompok, atau peristiwa tertentu).
2. Karakteristik:
 - a. Deskriptif: Menggambarkan fenomena secara objektif apa adanya.
 - b. Kualitatif: Mengeksplorasi makna di balik data deskriptif melalui wawancara, observasi, atau dokumen.
 - c. Jenis-Jenis:
 - 1) Studi Kasus (*Case Study*) : Analisis mendalam pada satu unit (kasus tunggal).
 - 2) Studi Deskriptif Kualitatif Dasar : Menjelaskan fenomena secara langsung tanpa terikat teori tebal.



masa mendatang. Namun, laporan dan rangkaian kasus memiliki keterbatasan intrinsik, seperti bias seleksi dan kurangnya kelompok kontrol, yang membatasi generalisasi. Tindak lanjut jangka panjang diperlukan dalam studi rangkaian kasus untuk memberikan wawasan yang relevan tentang daya tahan dan efektivitas pengobatan. Terlepas dari kekurangannya, laporan dan rangkaian kasus memberikan kerangka kerja untuk penelitian komprehensif lebih lanjut. Seiring waktu, temuan awal ini berkembang menjadi studi kohort dan uji klinis acak (RCT) yang terstruktur dengan baik, yang memvalidasi atau menyangkal kemanjuran terapi dan hipotesis yang disarankan.

Studi *Case-Control* (kasus-kontrol) adalah penelitian observasional analitik yang membandingkan kelompok berpenyakit (kasus) dengan tidak berpenyakit (kontrol) untuk mencari faktor risiko secara retrospektif (melihat ke belakang). Sedangkan, *Cohort Studies* (studi kohort) mengamati kelompok terpapar dan tidak terpapar, lalu diikuti ke depan (prospektif) untuk melihat timbulnya penyakit/hasil.

1. Case-Control Study (Studi Kasus-Kontrol)

Pengertian: Metode ini dimulai dengan mengidentifikasi pasien yang sudah sakit (kasus) dan orang sehat (kontrol), lalu mencari paparan di masa lalu yang menyebabkan penyakit tersebut.

Sinonim: *Retrospective study* (penelitian retrospektif), *case-referent study*.

Contoh Penggunaan: Meneliti hubungan antara merokok (paparan) dengan kanker paru-paru (penyakit) dengan membandingkan pasien kanker paru-paru dan orang sehat, lalu menanyakan riwayat merokok mereka.

Kelebihan: Sangat baik untuk penyakit langka atau penyakit dengan masa laten panjang, efisien waktu dan biaya.

2. Cohort Study (Studi Kohort)

Pengertian: Penelitian observasional yang mengikuti satu kelompok individu (kohort) dari waktu ke waktu untuk membandingkan kejadian penyakit antara mereka yang terpapar faktor risiko dan yang tidak.

Sinonim: *Prospective study* (penelitian prospektif), *follow-up study* (studi tindak lanjut).

Contoh Penggunaan: Mengikuti 1.000 orang yang merokok dan 1.000 orang yang tidak merokok selama 10 tahun untuk membandingkan berapa banyak yang mengembangkan kanker paru-paru.

Kelebihan: Dapat menghitung insidensi penyakit secara langsung, dapat mempelajari lebih dari satu dampak dari satu paparan.

Perbedaan Utama: Arah : Case-control melihat ke belakang (retrospektif), Cohort melihat ke depan (prospektif). Pemilihan Subjek: *Case-control* memilih berdasarkan status penyakit, Cohort memilih berdasarkan status paparan

F. Cohort and case-control studies

Studi kohort melacak kelompok dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi hasilnya, sedangkan studi kasus-kontrol membandingkan orang dengan dan tanpa penyakit. Studi observasional ini memberikan wawasan yang signifikan tetapi kurang dapat diandalkan daripada RCT karena potensi variabel pengganggu.

Studi kohort prospektif melacak orang secara terus menerus, memastikan pengumpulan data yang andal sekaligus meminimalkan bias ingatan. Studi ini memberikan kontrol yang lebih besar atas faktor-faktor tetapi membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Studi retrospektif memeriksa data historis, menambahkan bias seleksi dan bergantung pada informasi yang tidak sempurna. Studi prospektif, terlepas dari potensi bias pengurangan dari peserta yang keluar, memberikan kesimpulan kausal yang lebih kuat dan lebih sedikit faktor pengganggu, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka dalam penelitian berbasis bukti.

1. Studi Kohort (*Cohort Studies*)

Pengertian: Studi observasional yang mengikuti sekelompok orang (*kohort*) dengan karakteristik tertentu, dipaparkan (*exposed*) atau tidak dipaparkan faktor risiko, kemudian diikuti (*follow-up*) ke depan (*prospektif*) untuk melihat kejadian penyakit (*outcome*).

Arah Penelitian: Prospektif (melihat ke depan), meski ada juga bentuk retrospektif yang menggunakan data masa lalu.

Tujuan Utama: Menentukan insidensi (kasus baru), risiko relatif, dan memahami riwayat alamiah penyakit.

Kelebihan: Sangat baik untuk mempelajari paparan yang jarang dan memastikan urutan waktu (paparan mendahului penyakit).

Kekurangan: Membutuhkan waktu lama, biaya besar, dan risiko partisipan mengundurkan diri (*loss to follow-up*).

Contoh: Mengamati sekelompok perokok dan bukan perokok selama 10 tahun untuk membandingkan insidensi kanker paru-paru.

2. Studi Kasus-Kontrol (*Case-Control Studies*)

Pengertian: Studi analitik yang membandingkan kelompok yang sudah sakit (kasus) dengan kelompok yang tidak sakit (kontrol) untuk mencari tahu faktor risiko yang terjadi di masa lampau (retrospektif).

Arah Penelitian: Retrospektif (melihat ke belakang).

Tujuan Utama: Mengidentifikasi faktor risiko potensial dan mengukur kekuatan hubungan menggunakan *Odds Ratio* (OR).

Kelebihan: Efisien secara waktu dan biaya, sangat cocok untuk mempelajari penyakit yang langka atau memiliki masa inkubasi panjang.

Kekurangan: Rentan terhadap bias ingatan (*recall bias*) karena bergantung pada ingatan subjek tentang masa lalu

Contoh: Membandingkan pasien kanker paru (kasus) dan pasien sehat (kontrol), lalu menanyakan riwayat merokok mereka di masa lalu.

G. Randomized Controlled Trials (RCT)

Uji coba terkontrol (CT) adalah eksperimen di mana peserta dialokasikan secara acak ke salah satu dari dua kelompok: intervensi atau kontrol. Pendekatan ini mengurangi bias seleksi dan menetapkan hubungan sebab-akibat, namun mungkin membutuhkan banyak sumber daya.

Uji coba terkontrol secara acak (RCT) adalah pendekatan yang ketat untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang menghasilkan bukti berkualitas tinggi untuk pengobatan. RCT meminimalkan bias, menciptakan lingkungan terkontrol, dan dapat menggunakan penyamaran (*blinding*) untuk membatasi bias pengamat dan peserta. Namun, RCT tunduk pada batasan etika, membutuhkan banyak sumber daya, tidak fleksibel, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Selain itu, kelompok atau terapi tertentu mungkin tidak memenuhi syarat untuk RCT, sehingga mengakibatkan kesenjangan bukti.

Randomized Controlled Trials (RCT) atau Uji Acak Terkendali adalah Metode evaluasi dampak yang menggunakan desain eksperimen terkontrol secara acak. Studi Prospektif yaitu Pasien diikuti dari waktu ke waktu untuk melihat hasil. Randomisasi yaitu Peserta secara acak dialokasikan ke kelompok perlakuan atau kontrol. Fungsi RCT Adalah Menguji kausalitas dan efektivitas intervensi. Contoh Penggunaan RCT yaitu Uji Klinis Obat Baru, menguji apakah obat baru lebih efektif dibandingkan plasebo atau pengobatan standar. Prosedur Medis/Bedah yaitu dengan menilai keamanan teknik operasi baru. Intervensi Kesehatan Masyarakat/Sosial. Mengevaluasi dampak program edukasi kesehatan atau intervensi diet. Sinonim Randomized Controlled

H. Systematic Review & Meta-Analysis

Tinjauan sistematis menggabungkan data dari beberapa penelitian berkualitas tinggi, biasanya RCT (*Randomized Controlled Trial*/Uji Coba Terkontrol Acak), untuk menawarkan wawasan yang lengkap. Tinjauan ini meminimalkan bias dan memberikan kesimpulan yang paling menentukan, sehingga sangat penting untuk pedoman klinis.

Kualitas makalah yang termasuk dalam tinjauan sistematis atau meta-analisis (MA) menentukan tingkat bukti yang diberikannya. Tinjauan sistematis berkualitas

tinggi bergantung pada investigasi yang kuat dan tingkat tinggi, seperti RCT, untuk memastikan hasil yang akurat. Namun, jika studi yang disertakan memiliki ketelitian ilmiah yang rendah, temuan tinjauan sistematis akan mencerminkan keterbatasan ini, menurunkan tingkat bukti. Teori ini menekankan pepatah "apa yang Anda tabur, itulah yang akan Anda tuai" — masukan berkualitas rendah memberikan hasil yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, penilaian yang cermat terhadap penelitian individual diperlukan saat melakukan tinjauan sistematis untuk mempertahankan kredibilitas dan relevansinya dalam mengarahkan praktik klinis berbasis bukti.

Tinjauan sistematis adalah bentuk penelitian yang memberikan ringkasan laporan medis tentang pertanyaan klinis tertentu, menggunakan metode eksplisit untuk mencari, menilai secara kritis, dan mensintesis literatur dunia secara sistematis. Hal ini sangat berguna dalam menyatukan sejumlah studi yang dilakukan secara terpisah, terkadang dengan temuan yang bertentangan, dan mensintesis hasilnya. Dengan memberikan ringkasan yang jelas dan eksplisit dari semua studi yang membahas pertanyaan klinis tertentu, tinjauan sistematis memungkinkan kita untuk mempertimbangkan seluruh rangkaian temuan relevan dari penelitian tentang topik tertentu, dan bukan hanya hasil dari satu atau dua studi. Tinjauan sistematis dapat digunakan untuk menentukan apakah temuan ilmiah dapat diandalkan dan digeneralisasikan di berbagai populasi, lingkungan, dan variasi pengobatan, atau apakah temuan bervariasi secara signifikan berdasarkan subkelompok tertentu.

Tinjauan sistematis yang dilakukan dengan baik, dengan atau tanpa meta-analisis, umumnya dianggap memberikan bukti terbaik untuk semua jenis pertanyaan karena didasarkan pada temuan dari berbagai studi yang diidentifikasi dalam pencarian literatur sistematis yang komprehensif. Namun, posisi tinjauan sistematis di puncak hierarki bukti bukanlah hal yang mutlak. Misalnya: Proses tinjauan sistematis yang ketat dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan dan oleh karena itu temuan dapat digantikan oleh bukti yang lebih baru. Ketelitian metodologis dan kekuatan temuan harus dinilai oleh pembaca sebelum diterapkan pada pasien. Uji Coba Terkontrol Acak (RCT) yang besar dan dilakukan dengan baik dapat memberikan bukti yang lebih meyakinkan daripada tinjauan sistematis dari RCT yang lebih kecil.

I. Penutup

Evidence-based practice (EBP) atau Praktik Berbasis Bukti adalah pendekatan yang menekankan penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan keputusan praktik kebidanan. EBP berlandaskan pada prinsip bahwa praktik kebidanan yang efektif dan efisien harus didasari oleh bukti ilmiah terkini, bukan hanya tradisi,

kebiasaan, atau preferensi pribadi. Implementasi EBP diharapkan dapat meningkatkan kualitas asuhan kebidanan serta hasil kesehatan ibu dan bayi. EBP membantu bidan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam berbagai situasi kebidanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi praktik kebidanan. EBP adalah pendekatan sistematis untuk pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. EBP menggabungkan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian profesional dan preferensi pasien untuk menghasilkan keputusan yang optimal.

Hierarki bukti menyediakan sistem penilaian yang membantu klinisi mengevaluasi struktur, kredibilitas, dan relevansi bukti. Tingkat bukti yang lebih tinggi, seperti tinjauan sistematis dan uji coba terkontrol secara acak, dianggap lebih andal karena menggunakan metodologi yang ketat dan memiliki risiko bias yang lebih rendah (. Sebaliknya, studi kasus dan pendapat ahli berada pada peringkat yang lebih rendah dalam skala tersebut. Meskipun demikian, setiap tingkat bukti dapat memberikan wawasan yang berharga, dan memilih bukti yang paling tepat memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap konteks klinis, termasuk kebutuhan dan preferensi individu, sumber daya yang tersedia, kerangka hukum dan etika, dan keahlian profesional. Oleh karena itu, bukti tingkat tinggi, seperti uji coba terkontrol secara acak, mungkin tidak selalu merupakan bentuk bukti yang paling tepat—terutama dalam situasi yang berpusat pada pengalaman manusia, seperti meningkatkan kualitas hidup—di mana bukti kualitatif atau tingkat yang lebih rendah dapat menawarkan panduan yang lebih bermakna.

Referensi

- Lusiana, Novita. 2015. Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish
- Pratiwi dan Tombokan.2024. Buku Evidance Based Dalam Kebidanan. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management (NEM)
- Racmawati,dkk. 2025. Buku Ajar Evidance dalam Praktik Kebidanan. Jakarta: PT Optimal Untuk Negeri.
- Vitania, dkk. 2024. Buku Ajar Evidance based dalam Praktik Kebidanan. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management (NEM)
- Reffita, dkk. 2024. Buku Ajar Evidance dalam Praktik Kebidanan. Jakarta: PT. Nuansa Fajar Cemerlang

- Kusumawardani dan Rosyidah. 2020. Buku Ajar Evidence Based Midwifery. Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press
- Rahyani dan Hakimi. 2021. Chritical Thinking Dalam Asuhan Kebidanan Berbasis Bukti. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hidayani, dkk. 2025. Asuhan Kebidanan Bebasis Bukti. Jakarta: PT Yapindo
- Jayanti. 2019. Evidence based Dalam Praktik Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish
- Hotimah. 2022. Teks Laporan Hasil Observasi dan Teks Eksposisi. Medan: Guepedia
- Widiana, dkk. 2025. Systematic Review dan Meta Analysis Teori dan Praktek. Malang: Media Nusa Creative.
- Ramayanti, dkk. 2023. Langkah Demi langkah Systematic Review Literatur Review dan Meta Analysis. Depok: Rajawali Pers.

BAB II

ADAPTASI GUIDELINE INTERNASIONAL KE KONTEKS INDONESIA

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan global telah menghasilkan berbagai guideline internasional yang menjadi acuan dalam praktik klinis. Guideline ini disusun berdasarkan pendekatan *evidence-based practice* yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaik, pengalaman klinis, serta preferensi pasien. Organisasi internasional seperti WHO, NICE, dan CDC secara rutin memperbarui pedoman tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Namun demikian, penerapan guideline internasional secara langsung di Indonesia seringkali menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial budaya, tingkat pendidikan masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, serta ketersediaan sumber daya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi standar global.

Sebagai contoh, guideline terkait kesehatan ibu dan anak yang dikembangkan secara global belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia yang memiliki keterbatasan akses fasilitas kesehatan. Selain itu, faktor kepercayaan masyarakat terhadap praktik tradisional juga mempengaruhi keberhasilan implementasi guideline. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses adaptasi guideline internasional ke dalam konteks lokal Indonesia. Adaptasi ini bertujuan agar guideline tetap berbasis bukti namun dapat diterapkan secara realistis, efektif, dan berkelanjutan.

B. Konsep Guideline Internasional

Guideline internasional merupakan seperangkat rekomendasi sistematis yang disusun berdasarkan bukti ilmiah terbaik untuk membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis maupun kebijakan kesehatan. Guideline ini dikembangkan oleh organisasi internasional yang memiliki kredibilitas tinggi melalui proses metodologi yang ketat, transparan, serta berbasis penelitian terkini, sehingga dapat menjadi acuan dalam praktik pelayanan kesehatan secara global (World Health Organization, 2018). Dalam konteks pelayanan kesehatan, guideline tidak

hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin keselamatan pasien, serta mengurangi variasi praktik klinis yang tidak perlu. Dengan adanya guideline, tenaga kesehatan memiliki rujukan yang jelas dalam memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas. Selain itu, guideline juga menjadi dasar dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan (Susanto et al., 2021).

Secara konseptual, guideline memiliki perbedaan dengan protokol atau standar. Guideline bersifat lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi tenaga kesehatan untuk menyesuaikan keputusan klinis berdasarkan kondisi pasien, ketersediaan sumber daya, serta konteks lokal. Fleksibilitas ini menjadi penting karena setiap setting pelayanan kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman kondisi sosial dan geografis (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dalam sistem pelayanan kesehatan, guideline memiliki berbagai tujuan penting yang saling berkaitan. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan praktik berbasis bukti ilmiah. Dengan mengikuti guideline, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Selain itu, guideline juga berperan dalam menjamin keselamatan pasien dengan meminimalkan risiko kesalahan medis, karena setiap tindakan yang dilakukan telah melalui proses kajian ilmiah yang ketat. Di sisi lain, guideline juga membantu mengurangi variasi praktik klinis antar tenaga kesehatan, sehingga tercipta keseragaman dalam pelayanan. Hal ini sangat penting untuk menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas. Guideline juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis serta acuan dalam penyusunan kebijakan kesehatan oleh pemerintah dan institusi terkait (World Health Organization, 2018).

Penyusunan guideline internasional didasarkan pada prinsip *evidence-based practice* (EBP), yaitu pendekatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien. Bukti ilmiah yang digunakan biasanya berasal dari penelitian dengan tingkat validitas tinggi seperti uji klinis, meta-analisis, dan *systematic review*. Namun demikian, bukti ilmiah saja tidak cukup, karena pengalaman dan keahlian klinis tenaga kesehatan juga berperan dalam menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, nilai dan preferensi pasien harus tetap diperhatikan agar pelayanan yang diberikan bersifat humanis dan berpusat pada pasien (*patient-centered care*) (Susanto et al., 2020).

Proses pengembangan guideline internasional dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan komprehensif. Tahapan ini dimulai dari identifikasi masalah

kesehatan yang memerlukan pedoman berbasis bukti, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan penilaian bukti ilmiah melalui metode *systematic review*. Setelah itu, dilakukan penyusunan rekomendasi berdasarkan kekuatan bukti yang tersedia. Rekomendasi tersebut kemudian dikaji melalui konsensus para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan validitas dan relevansinya. Sebelum dipublikasikan, guideline biasanya melalui tahap uji publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga dapat dilakukan revisi dan penyempurnaan. Setelah guideline dipublikasikan, proses evaluasi dan pembaruan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru (World Health Organization, 2018).

Beberapa organisasi yang menghasilkan guideline internasional antara lain:

1. *World Health Organization* (WHO), mengembangkan guideline global terutama untuk kesehatan masyarakat dan negara berkembang.
2. *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE), berbasis di Inggris, fokus pada pelayanan klinis dan kebijakan kesehatan.
3. *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), Fokus pada pencegahan penyakit dan kesehatan masyarakat.
4. *International Federation of Gynecology and Obstetrics* (FIGO), Khusus dalam bidang kesehatan reproduksi dan kebidanan.

C. Konteks Sistem Kesehatan Indonesia

1. Struktur Sistem Kesehatan

Sistem kesehatan Indonesia merupakan suatu tatanan yang kompleks, dinamis, dan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sistem ini dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kondisi sosial ekonomi maupun geografis. Dalam implementasinya, sistem kesehatan Indonesia mengadopsi pendekatan berjenjang yang terdiri dari pelayanan primer, sekunder, dan tersier, yang saling terhubung melalui sistem rujukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pelayanan kesehatan primer merupakan garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Pada tingkat ini, masyarakat pertama kali berinteraksi dengan sistem kesehatan melalui fasilitas seperti Puskesmas, Posyandu, klinik pratama, serta praktik mandiri tenaga kesehatan. Puskesmas memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama, yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

2022). Selain itu, Posyandu sebagai bentuk pelayanan berbasis masyarakat berperan penting dalam pemantauan tumbuh kembang anak, imunisasi, serta edukasi kesehatan ibu dan anak. Pendekatan ini sejalan dengan upaya peningkatan kesehatan berbasis komunitas yang terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Rasni et al., 2020).

Tingkat pelayanan sekunder, pelayanan kesehatan diberikan oleh rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta yang menyediakan pelayanan spesialis. Fasilitas ini menjadi rujukan dari pelayanan primer ketika kasus tidak dapat ditangani pada tingkat pertama. Pelayanan sekunder berfokus pada upaya kuratif dan rehabilitatif dengan dukungan tenaga medis spesialis serta fasilitas penunjang yang lebih lengkap. Sistem rujukan berjenjang ini merupakan salah satu karakteristik utama sistem kesehatan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan penggunaan sumber daya kesehatan secara optimal (World Bank, 2021).

Pelayanan kesehatan tersier merupakan tingkat pelayanan tertinggi yang disediakan oleh rumah sakit rujukan nasional atau rumah sakit pendidikan. Fasilitas ini menangani kasus-kasus kompleks yang membutuhkan teknologi canggih dan tenaga subspesialis. Selain berfungsi sebagai pusat pelayanan, fasilitas tersier juga memiliki peran dalam pendidikan dan penelitian kesehatan. Namun demikian, akses terhadap pelayanan ini masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kepulauan (Agustina et al., 2021).

Secara keseluruhan, sistem kesehatan Indonesia mengedepankan pendekatan promotif dan preventif sebagai upaya utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma sehat yang menekankan pentingnya pencegahan penyakit sebelum terjadi, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

2. Faktor Sosial Budaya

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan tradisi yang sangat kaya. Keberagaman ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kesehatan masyarakat, baik dalam hal persepsi terhadap penyakit, pola pencarian pengobatan, maupun praktik perawatan kesehatan sehari-hari. Oleh karena itu, faktor sosial budaya menjadi aspek yang sangat penting dalam implementasi pelayanan kesehatan, termasuk dalam adaptasi guideline internasional (Susanto et al., 2020).

Salah satu fenomena yang masih banyak ditemukan di masyarakat adalah kepercayaan terhadap dukun bayi dalam proses persalinan. Meskipun tenaga

kesehatan seperti bidan telah tersedia, sebagian masyarakat masih memilih menggunakan jasa dukun bayi karena adanya faktor kepercayaan, kedekatan emosional, serta nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kesehatan tidak hanya bersifat medis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya (Susanto et al., 2021). Selain itu, terdapat berbagai pantangan makanan pada ibu hamil yang dapat berdampak pada status gizi ibu dan janin. Beberapa masyarakat masih mempercayai larangan konsumsi makanan tertentu yang sebenarnya memiliki kandungan gizi tinggi, seperti protein hewani. Praktik ini dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil dan berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada anak (Hafid & Nasrul, 2021).

Praktik tradisional juga terlihat dalam perawatan bayi, seperti penggunaan ramuan herbal atau metode perawatan tertentu yang tidak selalu sesuai dengan prinsip medis modern. Meskipun beberapa praktik tradisional memiliki manfaat, namun tidak semuanya didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dalam mengintegrasikan praktik tradisional dengan pelayanan kesehatan modern (Susanto et al., 2020). Faktor sosial budaya ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kompetensi budaya (*cultural competence*) agar mampu memberikan pelayanan yang sensitif, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat (Marmot et al., 2020).

3. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem kesehatan Indonesia. Keterbatasan ini mencakup tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, serta akses terhadap layanan kesehatan, yang secara langsung mempengaruhi kualitas dan pemerataan pelayanan (World Bank, 2021).

Distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih belum merata, dengan kecenderungan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan daerah pedesaan dan terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan secara optimal. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan derajat kesehatan antar wilayah (Agustina et al., 2021). Selain itu, distribusi fasilitas kesehatan juga belum merata. Daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, sementara daerah terpencil seringkali mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam akses pelayanan kesehatan. Beberapa wilayah hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut atau udara dengan waktu tempuh yang lama, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus kesehatan. Hal ini menunjukkan pentingnya inovasi dalam pelayanan kesehatan, seperti pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis komunitas (World Health Organization, 2020).

4. Kebijakan Kesehatan Nasional

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi dasar dalam adaptasi dan implementasi guideline internasional agar sesuai dengan konteks lokal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Salah satu program utama adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang menekankan pendekatan berbasis keluarga dalam pelayanan kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan melalui kunjungan keluarga oleh tenaga kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah kesehatan secara menyeluruh, termasuk kesehatan ibu dan anak, gizi, serta penyakit menular dan tidak menular (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam bidang kesehatan. Target ini mencakup penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan status gizi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program yang terintegrasi dan berbasis bukti (United Nations, 2022).

Program percepatan penurunan stunting juga menjadi prioritas nasional. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai intervensi, baik spesifik maupun sensitif, untuk menurunkan prevalensi stunting. Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan dan kader kesehatan, sangat penting dalam implementasi program ini melalui edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang, serta pemberdayaan masyarakat (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2021; Merina et al., 2021).

D. Strategi Adaptasi Guideline

Adaptasi guideline internasional merupakan proses penting dalam memastikan bahwa rekomendasi berbasis bukti dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal. Proses ini tidak sekadar menerjemahkan guideline, tetapi melibatkan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi sosial budaya, sistem kesehatan, serta ketersediaan sumber daya di suatu negara, termasuk Indonesia (World Health Organization, 2018).

Pada dasarnya, strategi adaptasi dimulai dari pemilihan guideline yang relevan dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Tidak semua guideline internasional dapat langsung diterapkan, sehingga diperlukan kajian awal untuk menilai kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Proses ini melibatkan analisis terhadap kualitas guideline serta kekuatan bukti ilmiah yang mendasarinya (Susanto et al., 2021). Selanjutnya, dilakukan pengkajian terhadap konteks lokal. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan pemangku kebijakan perlu memahami kondisi masyarakat, termasuk nilai budaya, tingkat pendidikan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Penyesuaian ini penting agar guideline dapat diterapkan secara realistis dan tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Proses adaptasi juga menuntut adanya kolaborasi multidisiplin. Akademisi, praktisi kesehatan, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyusun guideline yang tidak hanya berbasis bukti, tetapi juga aplikatif. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa guideline dapat diterima oleh tenaga kesehatan dan masyarakat (Susanto et al., 2020).

Integrasi kearifan lokal menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan budaya seringkali menjadi kunci keberhasilan implementasi program kesehatan. Oleh karena itu, strategi adaptasi harus mampu mengakomodasi praktik lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip medis (Rasni et al., 2014).

Tahap akhir dari strategi adaptasi adalah uji coba dan evaluasi. Guideline yang telah disesuaikan perlu diuji dalam praktik untuk melihat efektivitasnya. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan guideline agar lebih optimal dalam penerapannya (World Health Organization, 2018).

E. Implementasi Dalam Praktik Kebidanan

Implementasi guideline yang telah diadaptasi menjadi tahap krusial dalam memastikan bahwa rekomendasi tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam praktik kebidanan,

implementasi guideline memiliki peran strategis karena bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Dalam pelayanan antenatal, guideline internasional memberikan standar terkait pemeriksaan kehamilan, deteksi dini risiko, serta edukasi kesehatan. Namun dalam praktik di Indonesia, implementasi guideline tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Bidan seringkali harus menghadapi keterbatasan akses, rendahnya kesadaran ibu hamil, serta pengaruh budaya yang masih kuat (Susanto et al., 2019).

Selain itu, implementasi guideline juga terlihat dalam upaya pencegahan stunting. Bidan berperan dalam memberikan edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang, serta pemberdayaan keluarga. Pendekatan berbasis keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi anak dan mencegah stunting (Merina et al., 2021).

Dalam pelayanan persalinan, guideline internasional menekankan pentingnya persalinan yang aman dengan tenaga kesehatan terlatih. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang memilih persalinan non-medis. Oleh karena itu, bidan perlu mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2018).

Peran bidan dalam implementasi guideline tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai fasilitator dan advokat kesehatan. Bidan harus mampu menjembatani antara rekomendasi ilmiah dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menuntut kompetensi yang tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga komunikasi dan sosial budaya (Susanto et al., 2021).

Pendekatan komunitas melalui Posyandu juga menjadi strategi penting dalam implementasi guideline. Melalui kegiatan ini, tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

F. Tantangan Dan Solusi

Implementasi guideline yang telah diadaptasi tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini dapat berasal dari tenaga kesehatan, sistem pelayanan, maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan tersebut agar guideline dapat diterapkan secara optimal (World Health Organization, 2018).

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman tenaga kesehatan terhadap guideline. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki akses atau

kemampuan untuk memahami guideline berbasis evidence secara mendalam. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan pelayanan (Susanto et al., 2021).

Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan yang sering ditemukan. Tenaga kesehatan yang telah terbiasa dengan praktik lama cenderung sulit menerima perubahan yang dibawa oleh guideline baru. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kebiasaan dan kepercayaan yang sulit diubah dalam waktu singkat (Rasni et al., 2014).

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya juga menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa guideline internasional memerlukan peralatan dan teknologi yang belum tersedia secara merata di Indonesia. Hal ini menuntut adanya fleksibilitas dalam implementasi serta inovasi dalam pelayanan (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap guideline (Susanto et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi inovatif dalam penyebaran dan implementasi guideline. Teknologi memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan luas bagi tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil (World Health Organization, 2018).

Pendekatan berbasis budaya menjadi strategi penting dalam mengatasi resistensi masyarakat. Dengan melibatkan tokoh masyarakat serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan nilai lokal, implementasi guideline dapat lebih diterima dan berkelanjutan (Susanto et al., 2019).

Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa guideline yang diterapkan memberikan hasil yang optimal. Melalui evaluasi, dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses implementasi (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

G. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Adaptasi Guideline

Tenaga kesehatan merupakan aktor kunci dalam proses adaptasi dan implementasi guideline internasional ke dalam konteks lokal Indonesia. Keberhasilan suatu guideline tidak hanya ditentukan oleh kualitas rekomendasi yang disusun, tetapi juga oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam memahami, menerjemahkan, dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Dalam hal ini, tenaga kesehatan tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menjembatani antara ilmu pengetahuan global dengan kebutuhan

masyarakat lokal (Susanto et al., 2021). Dalam menghadapi dinamika sistem kesehatan yang terus berkembang, tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kompetensi yang komprehensif, baik dalam aspek klinis maupun non-klinis. Kemampuan untuk mengintegrasikan bukti ilmiah dengan kondisi nyata di lapangan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keterbatasan sumber daya serta keberagaman budaya (World Health Organization, 2022). Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan dalam adaptasi guideline mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan.

Berikut Peran Tenaga Kesehatan dalam Adaptasi Guideline:

1. Sebagai pelaksana praktik berbasis bukti

Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan guideline dalam praktik pelayanan sehari-hari. Dalam hal ini, tenaga kesehatan harus mampu memahami isi guideline serta menyesuaikannya dengan kondisi pasien. Penerapan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) menjadi dasar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman bagi pasien (Susanto et al., 2020).

2. Sebagai penghubung antara guideline dan konteks local

Guideline internasional seringkali disusun berdasarkan kondisi negara maju yang memiliki sumber daya lebih baik. Oleh karena itu, tenaga kesehatan berperan dalam menyesuaikan guideline tersebut agar sesuai dengan kondisi lokal, termasuk keterbatasan fasilitas dan budaya masyarakat. Peran ini sangat penting agar guideline dapat diterapkan secara realistis dan efektif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

3. Sebagai edukator dan komunikator kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelayanan kesehatan berbasis guideline. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, kemampuan komunikasi yang efektif dan sensitif terhadap budaya menjadi sangat penting (Susanto et al., 2020).

4. Sebagai advokat kesehatan

Tenaga kesehatan juga berperan sebagai advokat yang memperjuangkan kepentingan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai kebutuhan di lapangan serta hambatan dalam implementasi guideline. Peran advokasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (World Bank, 2021).

5. Sebagai evaluator implementasi guideline

Tenaga kesehatan memiliki peran dalam mengevaluasi sejauh mana guideline telah diterapkan dan memberikan dampak terhadap pelayanan kesehatan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pemantauan indikator pelayanan serta umpan balik dari masyarakat (World Health Organization, 2020).

Dalam praktik kebidanan, peran bidan menjadi sangat strategis karena bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bidan tidak hanya memberikan pelayanan klinis, tetapi juga berperan dalam edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pencegahan masalah kesehatan seperti stunting. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas yang dilakukan oleh bidan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (Merina et al., 2021). Selain itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat, tenaga kesehatan harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar dapat mengikuti perkembangan guideline terbaru. Hal ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang memudahkan akses terhadap informasi kesehatan (World Health Organization, 2022).

H. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan Guideline

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa guideline yang telah diadaptasi dapat memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, implementasi guideline berpotensi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi harus menjadi bagian integral dari siklus adaptasi guideline (World Health Organization, 2020). Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses implementasi guideline. Hal ini penting untuk mengetahui apakah guideline telah diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan. Dalam konteks Indonesia, evaluasi menjadi semakin penting mengingat adanya variasi kondisi geografis, sosial budaya, dan sumber daya di setiap daerah (Agustina et al., 2021).

Berikut Aspek Evaluasi Guideline:

1. Evaluasi proses implementasi

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana guideline telah diterapkan oleh tenaga kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap guideline serta kesesuaian praktik dengan rekomendasi yang ada (World Health Organization, 2020).

2. Evaluasi hasil (outcome)

Evaluasi outcome dilakukan untuk menilai dampak implementasi guideline terhadap kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan dapat berupa penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, serta penurunan prevalensi stunting (United Nations, 2022).

3. Evaluasi penerimaan masyarakat

Selain aspek klinis, penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi indikator penting. Guideline yang baik harus dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada (Marmot et al., 2020).

4. Evaluasi ketersediaan sumber daya

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah fasilitas, tenaga kesehatan, dan sarana pendukung telah memadai untuk mendukung implementasi guideline. Keterbatasan sumber daya sering menjadi hambatan dalam penerapan guideline di lapangan (World Bank, 2021).

Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar dalam pengembangan guideline secara berkelanjutan. Pengembangan ini dilakukan untuk memastikan bahwa guideline tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, prinsip *evidence-based practice* tetap menjadi landasan utama dalam pembaruan guideline (World Health Organization, 2022).

Pengembangan guideline juga perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa guideline yang dihasilkan tidak hanya berbasis bukti, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dan diterima oleh masyarakat (World Bank, 2021). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan dan diseminasi guideline. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, serta memudahkan tenaga kesehatan dalam mengakses guideline terbaru. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki wilayah geografis yang luas dan beragam (World Health Organization, 2020).

I. Inovasi Dan Masa Depan Adaptasi Guideline Di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam proses adaptasi guideline internasional. Di era globalisasi dan digitalisasi, adaptasi guideline tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi mulai memanfaatkan berbagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasinya. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sistem

kesehatan di Indonesia dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (World Health Organization, 2022).

Salah satu inovasi yang semakin berkembang adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi kesehatan, telemedicine, serta sistem informasi kesehatan memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses guideline terbaru secara cepat dan mudah. Teknologi ini juga membantu dalam pengambilan keputusan klinis berbasis data serta meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam, pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan akses pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2020). Selain itu, inovasi dalam pendekatan pelayanan berbasis komunitas juga menjadi bagian penting dalam adaptasi guideline. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya peningkatan kesehatan, bukan hanya sebagai objek pelayanan. Keterlibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta keluarga dalam implementasi program kesehatan terbukti dapat meningkatkan keberhasilan intervensi, khususnya dalam program pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak (Merina et al., 2021).

Dalam menghadapi masa depan, adaptasi guideline juga perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Guideline tidak lagi bersifat statis, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi epidemiologi, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu melakukan pembaruan guideline secara cepat dan berbasis bukti (*real-time evidence-based update*) (World Health Organization, 2022).

Arah Pengembangan Adaptasi Guideline di Masa Depan, yaitu:

1. Integrasi teknologi digital dalam pelayanan kesehatan,

Pemanfaatan teknologi seperti telemedicine, rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan akan menjadi bagian penting dalam implementasi guideline di masa depan. Teknologi ini memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

2. Penguatan pendekatan berbasis komunitas,

Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan akan semakin diperkuat melalui pemberdayaan kader dan keluarga sebagai mitra tenaga kesehatan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan program kesehatan masyarakat.

3. Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan guideline terbaru dan teknologi kesehatan.

4. Kolaborasi lintas sektor

Adaptasi guideline tidak hanya melibatkan sektor kesehatan, tetapi juga sektor lain seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi determinan sosial kesehatan secara menyeluruh (Marmot et al., 2020).

5. Penguatan kebijakan berbasis bukti

Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti ilmiah serta mendukung implementasi guideline yang adaptif dan kontekstual (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Adaptasi guideline internasional di Indonesia diharapkan tidak hanya berfokus pada penerapan rekomendasi global, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi lokal yang dapat menjadi referensi bagi negara lain. Dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat peran masyarakat, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem kesehatan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

J. Penutup

Adaptasi guideline internasional ke dalam konteks Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan sistem kesehatan, guideline dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat penting dalam proses ini. Dengan kompetensi yang memadai dan pemahaman terhadap konteks lokal, tenaga kesehatan dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ke depan, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk terus mengembangkan guideline yang adaptif dan berbasis bukti.

Referensi

- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, S., Achadi, E. L., & Khusun, H. (2021). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet Regional Health – Southeast Asia*, 1, 100001.
- Ainy, F. N., Susanto, T., & Susumaningrum, L. A. (2021). The relationship between environmental sanitation of family and stunting among under-five children. *Nursing Practice Today*, 8(3), 173–178. <https://doi.org/10.18502/npt.v8i3.5932>
- Allen, L. N., Nicholson, B. D., Yeung, B. Y. T., & Goiana-da-Silva, F. (2020). Implementation of non-communicable disease policies. *The Lancet Global Health*, 8(1), e50–e51.
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., & Horton, S. (2020). Evidence-based interventions for maternal and child health. *The Lancet*, 395(10225), 415–428.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). *Evidence-based public health practices*. CDC.
- Darmstadt, G. L., Bhutta, Z. A., Cousens, S., Adam, T., Walker, N., & de Bernis, L. (2020). Evidence-based, cost-effective interventions. *The Lancet*, 365(9463), 977–988.
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2021). *Pedoman pelaksanaan program percepatan penurunan stunting*. Kementerian Kesehatan RI.
- Hafid, F., & Nasrul, N. (2021). Determinants of stunting in Indonesia. *Public Health Nutrition*, 24(8), 2345–2353.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Profil kesehatan Indonesia 2019*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Profil kesehatan Indonesia 2020*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Transformasi sistem kesehatan Indonesia*. Kemenkes RI.
- Krishna, A., Mejía-Guevara, I., McGovern, M., Aguayo, V. M., & Subramanian, S. V. (2020). Trends in child stunting in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, 16(S2), e12941.
- Marmot, M., Allen, J., Boyce, T., Goldblatt, P., & Morrison, J. (2020). *Health equity in*

- England: The Marmot review 10 years on.* Institute of Health Equity.
- Merina, M., Susanto, T., Rasni, H., & Susumaningrum, L. A. (2021). Family-based intervention in reducing stunting. *Journal of Pediatric Nursing*, 59, e12–e18.
- Ministry of Health Indonesia. (2021). *Indonesia health sector review*. World Bank.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2021). *Developing NICE guidelines: The manual*. NICE.
- Nugroho, A., & Rahayu, S. (2022). Implementation of evidence-based practice in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(2), 145–152.
- Rasni, H., Susanto, T., & Susumaningrum, L. A. (2020). Community-based health intervention. *Journal of Nursing Practice*, 4(1), 25–32.
- Susanto, T., Rasni, H., Susumaningrum, L. A., Rahmawati, I., & Yunanto, R. A. (2020). Caring based on local wisdom. *Journal of Pediatric Nursing*, 55, e270–e278.
- Susanto, T., Yunanto, R. A., Rasni, H., & Susumaningrum, L. A. (2021). Multi-level intervention in community health. *HIV and AIDS Review*, 20(2), 78–84.
- United Nations. (2022). *Sustainable Development Goals report 2022*. United Nations.
- World Bank. (2021). *Improving health system performance in Indonesia*. World Bank.
- World Health Organization. (2020). *WHO guideline on health policy and system support*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Standards for improving quality of maternal and newborn care*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *Guideline adaptation manual*. WHO.

BAB III

IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED MIDWIFERY (EBM) DALAM ANTE NATAL CARE (ANC), INTRA NATAL CARE(INC), DAN POST NATAL CARE (PNC)

A. Pendahuluan

Asuhan kebidanan pada dasarnya adalah seni dan ilmu yang berfokus pada kehidupan. Selama berabad-abad, bidan telah menjadi penjaga gerbang kesehatan ibu dan anak melalui pendampingan yang bersifat holistik. Namun, di abad ke-21 ini, praktik kebidanan tidak lagi cukup hanya bersandar pada pengalaman klinis semata atau tradisi yang diwariskan turun-temurun. Kita berada di era di mana setiap tindakan klinis dituntut untuk memiliki landasan ilmiah yang kuat melalui Evidence-Based Midwifery (EBM). Penelitian menyatakan pengaruh penggunaan aplikasi seluler selama kehamilan terhadap peningkatan pengetahuan ibu, perubahan perilaku, maupun luaran kesehatan perinatal. (Lisa M Daly, Dell Horey, Philippa F, Frances M Boyle, 2018)

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru dari SPRIN National Summit yang diadakan oleh POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) pada April 2026 AKI Nasional: Saat ini tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan tantangan besar mengingat target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah menekan angka tersebut hingga 77 per 100.000 kelahiran hidup. Lokasi Kejadian: Sebanyak 80% kematian ibu terjadi di fasilitas kesehatan, dengan mayoritas terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Hal ini menegaskan pentingnya asuhan INC dan PNC yang lebih presisi serta sistem rujukan yang lebih cepat. Penyebab Utama: Perdarahan hebat tetap menjadi penyebab tertinggi, yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dalam waktu emas 30 menit. Di sinilah teknologi pemantauan real-time menjadi krusial. Dinamika ini menuntut bidan untuk lebih proaktif dan presisi dalam melakukan deteksi dini komplikasi selama masa ANC (Antenatal Care), INC (Intranatal Care), hingga PNC (Postnatal Care). Di sinilah tantangan baru muncul: bagaimana seorang bidan dapat menyaring ribuan

informasi riset terbaru dan mengaplikasikannya secara efektif di tengah beban kerja yang tinggi?

Jawaban atas tantangan tersebut terletak pada integrasi teknologi. Teknologi tidak hadir untuk mengaburkan sentuhan kemanusiaan dalam asuhan kebidanan, melainkan sebagai alat bantu untuk memperkuat akurasi klinis. Transformasi kesehatan digital yang diusung oleh Kementerian Kesehatan RI saat ini, seperti integrasi platform SatuSehat, bukan sekadar digitalisasi data. Ini adalah upaya menciptakan ekosistem di mana bukti ilmiah (EBM) dapat diakses dan diimplementasikan secara real-time melalui sistem pendukung keputusan klinis, mobile health, hingga pemantauan jarak jauh. Dari penelitian menunjukkan bahwa mHealth dapat meningkatkan literasi kesehatan ibu, keterlibatan dalam perawatan antenatal, dan kepatuhan terhadap tindakan pencegahan (Fatma et al., 2026)

Buku ini disusun untuk menjawab kegelisahan para praktisi dan akademisi mengenai bagaimana menjembatani jarak antara teori EBM yang kompleks dengan realitas praktik di lapangan yang kini serba digital. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca akan diajak untuk memahami:

1. Bagaimana teknologi digital mentransformasi kunjungan ANC menjadi lebih interaktif dan prediktif.
2. Bagaimana alat bantu keputusan digital memastikan persalinan (INC) berjalan dengan intervensi medis yang minimal namun aman.
3. Bagaimana pengawasan masa nifas (PNC) dapat dilakukan secara berkelanjutan melampaui batas fisik fasilitas kesehatan.

Adapun tujuan Buku referensi ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi mahasiswa dan praktisi kebidanan dalam menavigasi asuhan kehamilan, persalinan, dan nifas di era modern. Dengan memadukan bukti ilmiah terkini dan inovasi teknologi, kita tidak hanya sekadar menjalankan prosedur, tetapi sedang membangun masa depan kesehatan ibu dan anak Indonesia yang lebih cerdas, tepat, dan bermartabat.

Selamat menyelami integrasi ilmu dan teknologi demi keselamatan generasi masa depan.

B. Transformasi Standar Asuhan: Dari Praktik Tradisional Ke Berbasis Bukti

Transformasi asuhan kebidanan bukan sekadar pergantian prosedur, melainkan pergeseran filosofis dari asuhan yang berbasis "kebiasaan klinis" (eminence-based) menuju asuhan yang berpijak pada data ilmiah yang tervalidasi (evidence-based). Di era transformasi digital ini, bukti ilmiah tidak lagi hanya statis di dalam jurnal, tetapi terintegrasi langsung ke dalam protokol layanan kesehatan digital.

1. Antenatal Care (ANC): Dari Kuantitas ke Kualitas Terintegrasi

Praktik tradisional sering kali hanya menekankan pada jumlah kunjungan (minimal 4 kali) tanpa standarisasi konten yang mendalam di setiap kontak. Transformasi EBM: Berdasarkan standar terbaru, fokus bergeser pada model WHO 2016/2022 Recommendation yang diadaptasi dalam kebijakan Kemenkes RI (minimal 6 kali kontak).

Integrasi Teknologi: Penggunaan USG oleh dokter pada trimester 1 dan 3 kini menjadi standar wajib yang terdata dalam sistem SatuSehat. Teknologi m-Health memungkinkan bidan memantau kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dan profil tekanan darah pasien secara real-time melalui dasbor digital. Bukti Ilmiah: Penapisan risiko preeklamsia melalui pemeriksaan Mean Arterial Pressure (MAP) dan Placental Growth Factor (PIGF) kini menggantikan sekadar observasi edema kaki tradisional.

2. Intranatal Care (INC): Dekonstruksi Medikalisasi Persalinan

Banyak praktik tradisional dalam persalinan yang dahulu dianggap membantu, namun bukti ilmiah terbaru menunjukkan bahwa intervensi rutin tersebut justru dapat membahayakan atau menghambat proses fisiologis. Praktik Tradisional vs EBM: Amniotomi rutin: Tidak lagi direkomendasikan kecuali ada indikasi medis yang jelas. Posisi telentang (Lithotomy): Bergeser ke posisi tegak (upright position) yang didukung oleh gravitasi dan memperluas panggul. Manuver Kristeller: Secara tegas dilarang karena risiko trauma organ dalam dan janin. Alat Bantu Keputusan: Implementasi Labor Care Guide (LCG) digital. Berbeda dengan partograf konvensional yang kaku dengan garis waspada/bertindak, LCG lebih fleksibel dalam menghargai durasi persalinan fisiologis setiap individu selama kondisi ibu dan janin stabil.(WHO, 2020)

3. Postnatal Care (PNC): Skrining Holistik dan Dukungan Berkelanjutan

Masa nifas sering kali menjadi "periode yang terlupakan". Tradisi lama sering kali hanya fokus pada penyembuhan luka fisik ibu dan pertumbuhan fisik bayi. Transformasi EBM: Pengakuan terhadap pentingnya kesehatan mental. Skrining depresi postpartum menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) kini menjadi standar asuhan rutin.

Teknologi: Penggunaan tele-lactation dan grup dukungan berbasis aplikasi memudahkan bidan memberikan intervensi segera saat terjadi masalah menyusui, tanpa harus menunggu kunjungan fisik yang mungkin terlambat. Keluarga merupakan salah satu elemen terkecil masyarakat. Keberadaan keluarga di masyarakat akan menentukan perkembangan masyarakat (Stanhope & Lancaster, 1996). Keluarga menjadi tempat sentral bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, sehingga keluarga menjadi salah satu aspek terpenting

dari keperawatan. Keluarga bersama dengan individu, kelompok dan komunitas adalah klien atau resipien keperawatan (Friedman et al., 2003). Keluarga secara empiris, disadari bahwa kesehatan para anggota keluarga dan kualitas kesehatan keluarga mempunyai hubungan yang erat (Isnaini et al., 2020). Keberadaan keluarga yang dinamis di lingkungan komunitas tersebut memerlukan pengawasan dan fasilitasi yang baik dari aspek kesehatan. Ketidaktahuan, ketidakmauan, dan ketidakmampuan keluarga dalam memfasilitasi tugas perkembangan dan melaksanakan tugas kesehatan keluarga akan mengakibatkan keluarga mengalami keadaan maladaptif dalam mencapai kemandirian keluarga (Isnaini et al., 2020). Kelas online calon ibu terbukti efektif memberikan perubahan perilaku ibu dalam menjalankan perannya sebagai orangtua dan bisa melewati fase letting go lebih cepat, (Yuliana et al., 2024). Hal ini memerlukan suatu fasilitas dari perawat keluarga dalam mengoptimalkan keluarga dalam mencapai tugas perkembangan dan kemandirian keluarga.

C. Implementasi Klinis EBM Dalam Deteksi Dini Komplikasi

1. Antenatal Care (ANC): Prediksi dan Penapisan Berbasis Biomarker & Biofisika

Implementasi EBM dalam ANC telah bergeser dari sekadar "menunggu gejala muncul" menjadi "memprediksi risiko sejak dini" melalui integrasi data objektif. Skrining Preeklamsia Trimester I: Bukti ilmiah terbaru merekomendasikan penapisan risiko preeklamsia sebelum usia kehamilan 16 minggu menggunakan kombinasi faktor risiko maternal, Mean Arterial Pressure (MAP), dan indeks pulsasi arteri uterina.

Deteksi Diabetes Melitus Gestasional (DMG): EBM mendukung penerapan One-Step Strategy dengan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) pada usia kehamilan 24–28 minggu bagi semua ibu hamil, bukan hanya mereka yang memiliki faktor risiko (skrining universal). Implementasi Teknologi: Penggunaan alat CTG (Cardiotocography) Portabel yang terhubung dengan ponsel pintar memungkinkan pemantauan kesejahteraan janin jarak jauh pada ibu dengan risiko tinggi (misal: hipertensi atau gerakan janin berkurang).

2. Intranatal Care (INC): Presisi Pemantauan melalui Labor Care Guide (LCG)

Dalam persalinan, implementasi EBM bertujuan untuk mendeteksi distosia (persalinan macet) dan gawat janin tanpa melakukan intervensi medis yang prematur. Penerapan WHO Labor Care Guide (LCG): (WHO, 2020)

LCG menggantikan partograf tradisional dengan menetapkan ambang batas kemajuan persalinan yang lebih klinis (misalnya, pembukaan serviks 1 cm per jam tidak lagi menjadi standar mutlak pada fase aktif). LCG membantu bidan

mendeteksi kapan persalinan benar-benar melambat dan memerlukan rujukan. Interpretasi Fetal Heart Rate (FHR): EBM menekankan penggunaan klasifikasi tiga tingkat (Kategori I, II, III) dalam interpretasi DJJ untuk menentukan tindakan segera. Hal ini mencegah tindakan operatif (Sectio Caesarea) yang tidak perlu pada kategori I dan memastikan tindakan cepat pada kategori III. Deteksi Dini HPP (Perdarahan Postpartum): Penggunaan kantong penampung darah (V-Drape) berskala mililiter untuk mengukur volume darah secara objektif, menggantikan estimasi visual yang sering kali meremehkan jumlah perdarahan hingga 30-50%.

3. Postnatal Care (PNC): Monitoring Hemodinamik dan Kesehatan Mental

Deteksi dini pada masa nifas berfokus pada komplikasi yang sering kali "tersembunyi" setelah ibu keluar dari fasilitas kesehatan. Skrining Hipertensi Postpartum: EBM menunjukkan bahwa preeklamsia dapat muncul pertama kali pada masa nifas. Penggunaan tensimeter digital mandiri oleh ibu di rumah yang datanya dikirim ke bidan secara berkala (tele-monitoring) efektif menurunkan risiko stroke postpartum. Penapisan Depresi Postpartum: Implementasi rutin kuesioner Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) pada kunjungan nifas ke-2 atau ke-3 (hari ke-10 s.d 14). Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi dini pada gangguan mood dapat mencegah gangguan ikatan (bonding) ibu-bayi dan risiko bunuh diri. Deteksi Infeksi (Sepsis Puerperalis): Penggunaan parameter qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) yang disederhanakan bagi bidan untuk mendeteksi gejala awal sepsis melalui pemantauan frekuensi napas, status mental, dan tekanan darah sistolik. Kemandirian keluarga dalam istilah sosial merupakan sikap mental sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran, dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab (UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga juga merupakan suatu sistem. Keluarga merupakan sistem terbuka sehingga dapat dipengaruhi oleh supra sistemnya, yaitu lingkungannya (masyarakat), dan sebaliknya sebagai sub sistem dari lingkungan (masyarakat) keluarga dapat mempengaruhi masyarakat (suprasistem). Oleh karena itu betapa pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk manusia sebagai anggota masyarakat yang sehat bio-psiko-sosial-spiritual. Jadi bila keluarga sebagai titik sentral pelayanan keperawatan, maka keluarga yang sehat akan mewujudkan generasi Emas 2045.

D. Aspek Psikososial dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bingkai EBM

Implementasi EBM yang komprehensif harus mengintegrasikan tiga pilar: bukti penelitian terbaik, keahlian klinis bidan, dan nilai-nilai serta preferensi pasien. Tanpa melibatkan aspek psikososial, asuhan kebidanan hanyalah prosedur medis tanpa jiwa.

1. Shared Decision Making (SDM) dalam Asuhan Antenatal

Pemberdayaan dimulai sejak masa kehamilan dengan memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar objek medis.

Implementasi Klinis: Bidan memberikan informasi berbasis bukti mengenai pilihan persalinan (misalnya: manfaat vs risiko induksi, penggunaan alat kontrasepsi pascasalin) menggunakan alat bantu visual atau aplikasi digital.

Bukti EBM: Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan risiko trauma pascasalin yang lebih rendah.

Dukungan Teknologi: Penggunaan aplikasi birth plan digital membantu ibu menyusun preferensi persalinannya yang dapat diakses oleh tim medis secara real-time.

2. Respectful Maternity Care (RMC) dalam Persalinan

RMC adalah standar EBM yang menekankan pada perlindungan martabat, privasi, dan hak-hak perempuan selama proses persalinan.(WHO, 2025)

Pendampingan Persalinan: Bukti kuat (Cochrane Review) menunjukkan bahwa kehadiran pendamping (suami atau keluarga) menurunkan durasi persalinan dan kebutuhan akan tindakan operatif atau analgesia epidural.

Kebebasan Bergerak: EBM mendukung perempuan untuk memilih posisi bersalin yang paling nyaman bagi mereka (seperti berjongkok atau miring), yang secara fisiologis membantu penurunan kepala janin dan mengurangi nyeri. Pencegahan Kekerasan Kebidanan (Obstetric Violence): EBM melarang tindakan medis tanpa persetujuan (informed consent) yang jelas, seperti pemeriksaan dalam yang terlalu sering atau episiotomi rutin.

Meskipun sebagian besar perempuan menggambarkan pengalaman persalinan mereka sebagai pengalaman yang penuh hormat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal perawatan yang tepat waktu dan adil. Mengatasi keterlambatan dan mengurangi diskriminasi, khususnya di lingkungan layanan kesehatan publik, sangat penting untuk memastikan bahwa semua perempuan menerima perawatan persalinan yang bermartabat dan berpusat pada individu, terlepas dari latar belakang mereka. (Shafqat et al., 2025). Sebagai pedoman tenaga Kesehatan dalam menanggulangi kekerasan ibu dan anak

dibuatlah pedoman oleh Kemenkes sebagai rujukan dalam bertindak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)

3. Kesehatan Mental dan Parenting Self-Efficacy pada Masa Nifas

Transisi menjadi ibu merupakan periode psikososial yang rentan. Pemberdayaan pada masa ini difokuskan pada penguatan kepercayaan diri ibu.

Dukungan Menyusui: Implementasi IMD (Inisiasi Menyusui Dini) dan asuhan rawat gabung (rooming-in) didukung oleh EBM untuk meningkatkan produksi oksitosin yang berperan dalam kontraksi uterus sekaligus membangun ikatan batin (bonding).

Skrining Psikososial: Deteksi dini terhadap baby blues dan depresi postpartum melalui kuesioner digital (EPDS) memungkinkan intervensi psikologis lebih awal sebelum berdampak pada tumbuh kembang bayi. Literasi Kesehatan Digital: Memberdayakan ibu dengan sumber informasi digital yang tervalidasi agar mereka mampu menyaring mitos dan informasi salah (hoax) seputar perawatan bayi di lingkungan sosial mereka. Selain itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam mendukung implementasi IMD dan pemberian ASI (Hutagaol, 2019)

E. Penutup

Perjalanan kita menyusuri implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM) dalam asuhan ANC, INC, dan PNC telah membawa kita pada satu kesimpulan fundamental: Menyongsong Masa Depan Kebidanan yang Presisi dan Humanis. Bidan masa depan adalah mereka yang mampu mengawinkan ketajaman bukti ilmiah dengan kecanggihan teknologi, tanpa sedikit pun melepaskan sentuhan kasih sayang kepada pasien.

Transformasi standar asuhan yang telah kita bahas—mulai dari dekonstruksi praktik tradisional yang tidak lagi relevan hingga pemanfaatan teknologi deteksi dini bukanlah upaya untuk melakukan medikalisasi terhadap proses alami kehidupan. Sebaliknya, digitalisasi dan penerapan EBM adalah benteng perlindungan bagi martabat perempuan. Dengan teknologi, kita memangkas waktu respons komplikasi; dengan bukti ilmiah, kita menghindarkan ibu dari intervensi medis yang tidak perlu.

Integrasi teknologi dalam bingkai EBM bukan sekadar tentang kemahiran mengoperasikan perangkat digital atau platform seperti SATUSEHAT. Hal ini adalah tentang perubahan paradigma sebuah komitmen untuk terus belajar (lifelong learning) dan beradaptasi terhadap perubahan demi keselamatan ibu dan bayi. Pemberdayaan perempuan dan aspek psikososial yang telah diuraikan

mengingatkan kita bahwa di balik setiap data digital dan angka klinis, ada seorang ibu yang mendambakan rasa aman, dihormati, dan didengarkan.

Buku ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai tumpukan teori di rak perpustakaan, melainkan menjadi panduan praktis yang hidup dalam setiap asuhan yang Ibu/Bapak berikan. Tantangan kesehatan maternal di Indonesia memang masih besar, namun dengan kompetensi yang berlandaskan bukti dan dukungan teknologi yang tepat, kita memiliki peluang lebih besar untuk menekan angka kematian ibu dan bayi ke titik terendah dalam sejarah bangsa ini.

Mari kita terus melangkah, menjadi bidan yang tidak hanya terampil secara tangan (hands-on), tetapi juga cerdas secara data (data-driven) dan hangat secara hati (heart-centered). Demi generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan tangguh.

Sebagai Pesan Penutup untuk Mahasiswa dan Praktisi:

"Teknologi adalah alat, bukti ilmiah adalah kompas, namun empati adalah jiwa dari asuhan kebidanan. Jadilah bidan yang mampu menguasai ketiganya secara selaras."

Referensi

- Fatma, Y. A., Mumtazah, N., Fadilah, N., Aminarti, D., Lubis, D. H., Ritonga, M., Tinggi, S., Kesehatan, I., Kesehatan, L., & Hamil, W. (2026). MPERAN TEKNOLOGI MHEALTH DALAM PROMOSI DAN PENCEGAHAN MATERNAL HEALTH UNTUK RESILIENSI KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DESA LALANG. *Forum Ilmiah Dan Diskusi Mahasiswa (FORISMA) Ke VII*, 683–689.
- Hutagaol, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Laktasi dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Komputer Dan Sains, Imd*, 672–679.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *RUJUKAN, PEDOMAN PELAYANAN DAN TERHADAP, KASUS KEKERASAN (KtP/A), PEREMPUAN DAN ANAK KESEHATAN, BAGI PETUGAS*. Jakarta Indonesia.
- Lisa M Daly, Dell Horey, Philippa F, Frances M Boyle, V. F. (2018). The Effect of Mobile App Interventions on Influencing Healthy Maternal Behavior and Improving Perinatal Health Outcomes: Systematic Review. *Journal Of Participatory Medicine*, 6(8).
- Shafqat, N., Jyotika, K., Pushpalatha, K., Radha, K., & Mondal, M. (2025). Respectful maternity care during childbirth: postnatal women ' s perspectives . Cross-

sectional study from central India : February -December 2023 Cuidado materno respetuoso durante el parto : perspectivas de mujeres en el posparto . Estudio de corte tra. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 0225(June).

WHO. (2020). *WHO Labor care guide user manual*. Retrieved from <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/94326918-1f91-49a2-a857-12831cd51b91/content>

WHO. (2025). *How a new compendium by WHO and partners will lead to a higher quality of care*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/prioritizing-respectful-care-for-pregnant-women--mothers-and-babies>

Yuliana, W., R, R. H. R., & Nulhakim, B. (2024). *EFEKTIFITAS KELAS ONLINE CALON IBU TERHADAP WAKTU PENCAPAIAN ADAPTASI PSIKOLOGIS (LETTING GO) PADA IBU POSTPARTUM*. 4, 30–36.

BAB IV

AUDIT MATERNAL DAN PERBAIKAN MUTU PELAYANAN

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu dan bayi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka kematian ibu dan perinatal masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses saja belum cukup, melainkan perlu diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (World Health Organization, 2019)

Salah satu pendekatan yang direkomendasikan secara global adalah penerapan Maternal Death Surveillance and Response (MDSR) atau Surveilans dan Respons Kematian Ibu. MDSR merupakan sistem yang mengintegrasikan proses identifikasi, pelaporan, analisis, serta tindak lanjut terhadap setiap kematian ibu sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan data secara real-time untuk menghasilkan intervensi yang tepat dan cepat (World Health Organization, 2016).

Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan bagian penting dalam sistem MDSR, yang berfungsi sebagai mekanisme evaluasi mendalam terhadap kasus kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Melalui audit, berbagai faktor penyebab—baik medis maupun non-medis—dapat diidentifikasi secara komprehensif. Hasil dari audit ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi dan tindakan perbaikan guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Pendekatan surveilans dan respons dalam audit maternal perinatal tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada implementasi tindak lanjut yang konkret. Hal ini mencakup perbaikan sistem rujukan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penguatan manajemen pelayanan kesehatan. Dengan demikian, audit tidak berhenti pada tahap evaluasi, tetapi berlanjut hingga pada perubahan nyata dalam praktik pelayanan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, mekanisme, serta implementasi Audit Maternal Perinatal dalam kerangka surveilans dan respons. Diharapkan pembaca, khususnya tenaga kesehatan, dapat memahami

pentingnya integrasi antara pengumpulan data dan tindak lanjut sebagai upaya strategis dalam menurunkan angka kematian ibu dan perinatal serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

B. Konsep Dan Dasar Audit Maternal

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN) di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, namun masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Setiap tahun diperkirakan terdapat sekitar 14.640 kematian ibu dan 72.000 kematian bayi baru lahir, berdasarkan AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup dan AKN sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup. Sebagian besar kematian tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi yang tepat. Kematian bayi baru lahir lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah, sementara kematian ibu lebih sering ditemukan pada kelompok dengan tingkat pendidikan rendah, serta pada usia di bawah 20 tahun dan antara 40 hingga 49 tahun. Selain itu, sebagian besar kematian ibu dan bayi baru lahir terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu masing-masing sekitar 79,5% dan 81%, dengan proporsi terbesar di rumah sakit. Namun demikian, masih terdapat kematian yang terjadi di rumah serta dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan suatu kegiatan penelaahan sistematis terhadap kasus kesakitan dan kematian ibu serta bayi, yang dilakukan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Audit ini menjadi bagian dari pendekatan *Surveilans dan Respons*, yaitu suatu sistem yang tidak hanya mengumpulkan data kematian ibu dan perinatal, tetapi juga menindaklanjuti hasil analisis untuk perbaikan pelayanan secara berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Pendekatan *surveilans dan respons* menekankan bahwa setiap kasus kematian ibu dan bayi harus dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara sistematis. Dengan demikian, audit maternal perinatal tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pelaksanaan AMP bertujuan untuk menurunkan hingga mengeliminasi kematian ibu dan perinatal yang sebenarnya dapat dicegah. Upaya ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta memanfaatkan data dan informasi dari setiap kasus kematian ibu dan perinatal, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan intervensi serta pemantauan dampaknya terhadap sistem kesehatan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Adapun manfaat audit maternal perinatal antara lain:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi
2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal dan perinatal
3. Mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dicegah
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pembelajaran kasus
5. Memperbaiki sistem rujukan dan manajemen pelayanan kesehatan

Dengan adanya audit, setiap kasus dapat menjadi sumber pembelajaran untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan audit maternal perinatal harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Berorientasi pada perbaikan mutu pelayanan

Pelaksanaan audit maternal perinatal harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses audit berjalan secara efektif, objektif, dan memberikan manfaat dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Prinsip pertama yang harus dijunjung tinggi adalah kerahasiaan, yaitu menjaga privasi dan keamanan seluruh data pasien yang digunakan dalam proses audit. Informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan evaluasi dan tidak boleh disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab.

2. Tidak menyalahkan (non-blaming), fokus pada perbaikan sistem

Prinsip berikutnya adalah tidak menyalahkan (non-blaming), yang menekankan bahwa audit bukan merupakan sarana untuk mencari kesalahan individu atau pihak tertentu, melainkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, tenaga kesehatan diharapkan dapat berpartisipasi secara terbuka tanpa rasa takut, sehingga proses audit dapat berjalan lebih jujur dan transparan.

3. Objektivitas, berdasarkan data dan fakta

Selain itu, prinsip objektivitas juga sangat penting dalam pelaksanaan audit. Setiap analisis yang dilakukan harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat dan rekomendasi yang relevan dalam perbaikan pelayanan.

4. Keterbukaan, melibatkan berbagai pihak terkait

Prinsip keterbukaan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari audit maternal perinatal. Pelaksanaan audit harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga diperoleh sudut

pandang yang komprehensif dalam menganalisis suatu kasus. Keterlibatan tim multidisiplin ini akan memperkaya diskusi serta meningkatkan kualitas hasil audit.

5. Kerahasiaan, yaitu menjaga privasi data pasien

Terakhir, seluruh proses audit harus berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Hasil audit tidak hanya berhenti pada tahap evaluasi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dan implementasi rekomendasi yang tepat. Dengan demikian, audit maternal perinatal dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran, perbaikan sistem, serta upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang

Prinsip non-blaming sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman bagi tenaga kesehatan dalam melakukan evaluasi, sehingga hasil audit dapat digunakan secara optimal untuk perbaikan pelayanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Ruang lingkup audit maternal perinatal mencakup seluruh pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Selain itu, audit juga mencakup aspek sistem pelayanan seperti ketersediaan fasilitas, kualitas tenaga kesehatan, serta efektivitas sistem rujukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Audit juga mempertimbangkan faktor non-medis seperti keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kondisi kesehatan ibu dan bayi. Dengan demikian, audit memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penyebab terjadinya kematian maternal dan perinatal.

Dalam perkembangannya, audit maternal menjadi bagian dari pendekatan surveilans dan respons yang menekankan pentingnya pencatatan, analisis, serta tindak lanjut terhadap setiap kasus kematian ibu dan perinatal. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan sistem secara berkelanjutan (Smith et al., 2017), (Ambarwati et al., 2023).

C. Mekanisme Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Dan Respons (AMP-SR)

Surveilans kematian ibu dan perinatal merupakan komponen utama dalam pelaksanaan AMP-SR yang bertujuan untuk memastikan setiap kejadian kematian tercatat dan dilaporkan secara sistematis. Surveilans dilakukan melalui proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan seluruh kasus kematian ibu dan bayi, baik yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022)

Proses ini melibatkan berbagai sumber data, seperti rumah sakit, puskesmas, bidan praktik mandiri, serta laporan dari masyarakat. Data yang terkumpul kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut dalam proses audit. Keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem surveilans. Sistem surveilans yang efektif memungkinkan deteksi dini permasalahan serta pengambilan keputusan yang tepat dalam upaya pencegahan kematian ibu (Smith et al., 2017).

Setelah data kematian dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan audit atau kajian kasus. Audit dilakukan dengan menelaah secara mendalam setiap kasus kematian ibu dan perinatal untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Proses audit meliputi tahap berikut:

1. Pengumpulan data klinis dan non-klinis

Proses audit maternal perinatal mencakup beberapa tahapan penting yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, baik data klinis maupun non-klinis, yang berkaitan dengan kasus kematian ibu dan perinatal. Data ini meliputi riwayat kesehatan, proses pelayanan yang diterima, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi pasien.

2. Analisis penyebab kematian

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab kematian untuk mengetahui faktor utama yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mempertimbangkan faktor non-medis yang mungkin berperan.

3. Identifikasi faktor keterlambatan (delay)

Tahap berikutnya adalah identifikasi faktor keterlambatan (delay), yang meliputi keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan dalam mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, serta keterlambatan dalam memperoleh pelayanan yang adekuat. Identifikasi ini penting untuk mengetahui titik-titik kelemahan dalam sistem pelayanan kesehatan.

4. Diskusi dalam tim audit multidisiplin

Seluruh hasil analisis kemudian dibahas dalam forum diskusi yang melibatkan tim audit multidisiplin. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap kasus serta merumuskan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang

Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak menyalahkan individu, melainkan berfokus pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan.

AMP-SR tidak berhenti pada tahap audit, tetapi dilanjutkan dengan respons atau tindak lanjut terhadap hasil kajian kasus. Respons merupakan langkah konkret yang diambil berdasarkan rekomendasi hasil audit untuk mencegah terulangnya kasus serupa (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Tindak lanjut dapat berupa:

1. Perbaikan sistem rujukan
2. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
3. Penyediaan sarana dan prasarana
4. Penguatan manajemen pelayanan kesehatan

Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan terhadap sistem kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan AMP-SR sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif tenaga kesehatan. Perawat, bidan, dan dokter memiliki peran penting dalam setiap tahapan, mulai dari pelaporan kasus hingga pelaksanaan tindak lanjut (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Peran tenaga kesehatan meliputi:

1. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus secara akurat

Peran tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR) mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Salah satu peran utama adalah melakukan pencatatan dan pelaporan kasus secara akurat dan lengkap, sehingga data yang digunakan dalam proses audit dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta menjadi dasar analisis yang tepat.

2. Berpartisipasi dalam proses audit dan diskusi kasus

Selain itu, tenaga kesehatan juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses audit, termasuk dalam kegiatan kajian kasus dan diskusi bersama tim multidisiplin. Keterlibatan ini penting untuk memberikan kontribusi pemikiran serta pengalaman klinis dalam mengidentifikasi penyebab dan faktor yang berkontribusi terhadap kejadian kematian ibu dan perinatal.

3. Mengimplementasikan rekomendasi hasil audit

Tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit. Implementasi ini meliputi penerapan perbaikan dalam praktik pelayanan, peningkatan kualitas tindakan klinis, serta penyesuaian prosedur kerja sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

4. Memberikan edukasi kepada masyarakat

Di samping itu, peran tenaga kesehatan juga mencakup pemberian edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait kesehatan ibu dan anak. Edukasi ini

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, tanda bahaya, serta pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, peran tenaga kesehatan tidak hanya terbatas pada pelayanan klinis, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh.

Sistem surveilans yang belum berjalan secara optimal masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan AMP-SR di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan komitmen serta peningkatan koordinasi antar tenaga kesehatan agar proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi (Ambarwati et al., 2023).

Di sisi lain, pelaksanaan audit maternal perinatal juga kerap menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek komunikasi dan koordinasi antar unit pelayanan, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia dalam sistem pelayanan kesehatan. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses audit serta kualitas hasil analisis yang dihasilkan (Mahudin et al., 2020).

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antar tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu, serta dukungan penuh dari manajemen fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan AMP-SR dapat berjalan secara efektif, berkesinambungan, dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

D. Faktor Penyebab Kematian Maternal dan Perinatal

Kematian ibu dan perinatal umumnya disebabkan oleh faktor medis yang berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Penyebab utama kematian ibu meliputi perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia/eklampsia), infeksi, serta komplikasi persalinan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Kematian perinatal merupakan kematian yang terjadi sejak usia kehamilan 28 minggu hingga tujuh hari setelah kelahiran. Kematian ini mencakup dua periode, yaitu kematian janin pada tahap akhir kehamilan dan kematian neonatal dini. Kematian perinatal sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan selama masa antenatal dan intranatal.

Secara umum, angka kematian perinatal tergolong tinggi dibandingkan dengan kelompok usia bayi lainnya. Kematian pada periode akhir janin merujuk pada kematian yang terjadi setelah usia kehamilan mencapai 28 minggu, sedangkan kematian neonatal dini adalah kematian yang terjadi pada bayi dalam tujuh hari pertama setelah lahir. Angka kematian perinatal (perinatal mortality rate atau PMR)

dihitung sebagai jumlah kelahiran mati ditambah kematian neonatal dini (hingga usia 7 hari) per 1.000 kelahiran hidup (Juwita et al., 2021).

Pada periode perinatal, penyebab kematian bayi antara lain asfiksia, prematuritas, infeksi, dan berat badan lahir rendah (BBLR). Faktor-faktor ini seringkali berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan selama masa kehamilan dan persalinan (World Health Organization, 2019).

Selain faktor medis, kematian ibu dan perinatal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-medis yang memiliki peran signifikan dalam menentukan outcome kesehatan. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai. Keterbatasan akses ini dapat berupa jarak fasilitas kesehatan yang jauh, keterbatasan transportasi, serta hambatan biaya yang menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat turut memengaruhi kemampuan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan mengambil keputusan yang tepat terkait pencarian pertolongan medis. Kondisi sosial ekonomi yang lemah juga berkontribusi terhadap rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi dan perawatan selama kehamilan.

Selain faktor tersebut, sistem pelayanan kesehatan yang belum optimal juga menjadi penyebab penting. Hal ini mencakup kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum efektifnya sistem rujukan antar fasilitas kesehatan. Kelemahan dalam sistem ini dapat menyebabkan keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif baik dari aspek individu, sosial, maupun sistem pelayanan kesehatan guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian Tabelak & Yurissetiowati, (2022) menunjukkan bahwa terdapat berbagai determinan kontekstual yang memengaruhi terjadinya kematian ibu. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu, yang umumnya berada pada tingkat sekolah dasar hingga menengah pertama. Selain itu, sebagian besar ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga atau petani musiman, serta memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan terkait rujukan medis. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah jarak fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang relatif jauh, keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah desa, serta kurangnya pemanfaatan pelayanan antenatal care (ANC). Kondisi ini diperburuk dengan adanya ibu hamil yang memiliki penyakit kronis atau risiko

tinggi, serta praktik persalinan di rumah yang masih dilakukan dengan bantuan dukun atau anggota keluarga.

Sebagai tenaga kesehatan dengan peran khusus dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan diharapkan dapat berpartisipasi aktif serta menjalin kerja sama yang saling melengkapi dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan profesional lainnya, guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi (Maesaroh et al., 2024)

Audit Maternal Perinatal memiliki peran penting dalam mengidentifikasi penyebab kematian ibu dan bayi secara komprehensif. Melalui proses audit, faktor medis dan non-medis dapat dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditemukan akar permasalahan yang sebenarnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Hasil audit kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi intervensi yang tepat. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan sistem pelayanan kesehatan secara berkelanjutan dan berbasis bukti (evidence-based) (Smith et al., 2017).

Dengan demikian, audit maternal perinatal tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kasus kesakitan dan kematian ibu serta bayi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam upaya pencegahan kematian maternal dan perinatal. Melalui proses analisis yang sistematis dan komprehensif, audit mampu mengidentifikasi berbagai faktor penyebab, baik yang bersifat medis maupun non-medis, sehingga dapat dirumuskan langkah intervensi yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, hasil audit juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan sistem pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Dengan pendekatan ini, audit maternal perinatal berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kesakitan dan kematian secara signifikan.

E. Peran Audit Maternal Perinatal Surveilans Dan Respons (AMP-SR) Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Melalui rangkaian proses yang sistematis, mulai dari identifikasi kasus, pengumpulan data, analisis, hingga evaluasi terhadap setiap kejadian kematian, AMP-SR mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan. Proses ini memungkinkan tenaga kesehatan dan pengelola layanan untuk memahami secara lebih mendalam berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kematian ibu dan perinatal.

Selain itu, AMP-SR juga berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kelemahan yang terdapat dalam sistem pelayanan kesehatan, baik dari aspek klinis maupun manajerial. Kelemahan tersebut dapat berupa keterlambatan penanganan, kurangnya kompetensi tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga belum optimalnya sistem rujukan. Dengan adanya identifikasi yang jelas terhadap permasalahan tersebut, AMP-SR dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, AMP-SR tidak hanya berperan sebagai mekanisme evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Implementasi hasil audit secara konsisten diharapkan mampu memperbaiki sistem pelayanan secara menyeluruh, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi secara signifikan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022)

Hasil yang diperoleh dari proses audit dimanfaatkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi klinis maupun manajerial. Informasi yang dihasilkan dari audit memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi, sehingga dapat digunakan untuk merancang strategi perbaikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Perbaikan tersebut dapat mencakup peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penyempurnaan prosedur pelayanan, serta penguatan sistem manajemen dan rujukan.

Dengan demikian, pelaksanaan AMP-SR tidak hanya terbatas sebagai alat evaluasi semata, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Melalui penerapan rekomendasi yang konsisten dan berkesinambungan, AMP-SR diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Salah satu komponen krusial dalam pelaksanaan AMP-SR adalah implementasi dari rekomendasi yang dihasilkan melalui proses audit. Rekomendasi tersebut harus disusun secara aplikatif, realistis, dan disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas sistem pelayanan kesehatan di masing-masing daerah. Hal ini penting agar rekomendasi tidak hanya berhenti sebagai hasil kajian, tetapi dapat benar-benar diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Implementasi rekomendasi dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penyempurnaan sistem rujukan agar lebih cepat dan efektif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan

kesehatan yang optimal. Selain itu, diperlukan pula dukungan manajemen dan kebijakan yang kuat agar proses implementasi dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi yang tepat dan terarah, diharapkan dapat terjadi perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, sehingga risiko kesakitan dan kematian dapat ditekan secara signifikan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Pelaksanaan rekomendasi hasil audit yang dilakukan secara efektif akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus dapat diimplementasikan secara praktis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan rekomendasi sangat bergantung pada keseriusan dalam penerapan serta konsistensi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

Dalam hal ini, komitmen dari seluruh pihak yang terlibat menjadi faktor kunci, baik tenaga kesehatan, manajemen fasilitas kesehatan, maupun pemangku kebijakan. Kerja sama yang baik antar tenaga kesehatan, dukungan manajemen dalam penyediaan sumber daya, serta adanya kebijakan yang mendukung akan memperkuat implementasi rekomendasi tersebut. Dengan demikian, upaya perbaikan mutu pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan AMP-SR. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana rekomendasi hasil audit telah dilaksanakan serta dampaknya terhadap sistem pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2016).

Melalui monitoring yang berkelanjutan, dapat diketahui keberhasilan intervensi yang telah dilakukan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut sehingga proses peningkatan mutu pelayanan dapat berjalan secara terus-menerus.

Selain itu, keterlibatan aktif tenaga kesehatan dalam proses audit dan tindak lanjut akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, AMP-SR tidak hanya meningkatkan kualitas sistem, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan.

Audit maternal yang baik dan berkualitas sangat bergantung pada kejujuran, keterbukaan, serta kemauan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses audit. Kejujuran dalam penyampaian data dan informasi kasus menjadi kunci utama agar

analisis yang dilakukan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, keterbukaan dalam diskusi memungkinkan setiap tenaga kesehatan untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, serta permasalahan yang dihadapi tanpa rasa takut disalahkan (Muliarini, 2020).

Kemauan untuk berpartisipasi secara aktif juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan audit maternal, karena proses ini memerlukan kerja sama tim yang solid dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, audit maternal dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai audit klinis, yaitu sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Audit maternal perinatal juga berperan sebagai sarana pemantauan sekaligus mendukung sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan. Agar fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan pengisian rekam medis yang lengkap dan akurat di setiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pelacakan kasus dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas melalui metode otopsi verbal, yaitu wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui riwayat penyakit, gejala, serta tindakan yang telah diterima sebelum pasien meninggal. Melalui proses ini, dapat diperkirakan penyebab kematian secara lebih tepat (Muliarini, 2020)

Pelaksanaan AMP-SR juga berperan dalam membangun budaya keselamatan pasien (patient safety) dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. Prinsip non-blaming dalam audit mendorong tenaga kesehatan untuk lebih terbuka dalam mengidentifikasi kesalahan dan mencari solusi bersama (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

F. Tantangan dan Upaya Penguatan Pelaksanaan AMP-SR

Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek sumber daya manusia, sistem pelayanan, serta dukungan kebijakan. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah keterbatasan tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelaksanaan audit, sehingga proses analisis kasus belum dilakukan secara optimal (Ambarwati et al., 2023).

Selain itu, permasalahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan juga menjadi hambatan penting. Data yang tidak lengkap, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya integrasi sistem informasi kesehatan dapat menghambat proses surveilans dan respons secara cepat dan tepat. Di sisi lain, masih terdapat kendala

dalam koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam sistem rujukan, yang menyebabkan keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal (Mahudin et al., 2020)

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya komitmen dan partisipasi sebagian tenaga kesehatan dalam pelaksanaan audit, yang dapat disebabkan oleh beban kerja yang tinggi maupun kurangnya pemahaman terhadap pentingnya AMP-SR. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, supervisi, serta penguatan budaya kerja yang mendukung pelaksanaan audit secara berkelanjutan.

Upaya penguatan pelaksanaan AMP-SR dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi, serta penguatan sistem rujukan yang lebih efektif dan responsif. Selain itu, dukungan dari manajemen fasilitas kesehatan dan pemangku kebijakan sangat diperlukan dalam bentuk regulasi, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dengan adanya upaya penguatan tersebut, diharapkan pelaksanaan AMP-SR dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu dan perinatal serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Referensi

- Ambarwati, N. D., Kartasurya, M. I., & Purnami, C. T. (2023). Implementation of Maternal Perinatal Surveillance and Response (AMP-SR) Audit in Indonesia: Scoping Review. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.30829/contagion.v5i1.14833>
- Juwita, R., Begum Suroyo, R., & Sibero, J. T. (2021). ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEJADIAN KEMATIAN PERINATAL DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 Analysis Of Influence Factors Of Maternal Mortality Case In Working Area Of Health And Family Planning Department Of Pidie Jaya District In 2020. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 2615–109. <https://e-koren.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-SDKI-2017->
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Audit Maternal Dan Perinatal – Surveilans Dan Respon (AMP-SR)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://repository.kemkes.go.id/book/872>

- Maesaroh, Khaeriyah, H. N., Rohaeni, E., Prihartini, A. R., Sartika, Noorlinda, Kumalasari, R., & Isnaeni, S. (2024). *Konsep kebidanan* (R. Setiawati (ed.)). CV. Elsi Pro.
- Mahudin, R., Patria Jati, S., Sariatmi Fakultas Kesehatan Masyarakat, A., & Diponegoro Semarang, U. (2020). FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEGIATAN AUDIT MATERNAL PERINATAL (AMP) DI KOTA SEMARANG (Study Kasus Pada Puskesmas Kedungmundu, Rumah Sakit Tugurejo dan Dinas Kesehatan Kota Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 323–327. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Muliarini, P. (2020). The reconstruction of Maternal Audit with the electronic health information System. *Soepra*, 5(2), 224. <https://doi.org/10.24167/shk.v5i2.2461>
- Smith, H., Ameh, C., Roos, N., Mathai, M., & van den Broek, N. (2017). Implementing maternal death surveillance and response: A review of lessons from country case studies. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1405-6>
- Tabelak, T. V. I., & Yurissetiowati. (2022). Pengaruh Determinan Kontekstual Terhadap Kematian Ibu Di Kabupaten Kupang. *Al-Insyirah Midwifery Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, 11(1), 52–61. <https://jurnal.stikes-alinsyirah.ac.id/index.php/kebidanan>
- World Health Organization. (2016). Time to respond: a report on the global implementation of maternal death surveillance and response (MDSR). *World Health Organization*.
- World Health Organization. (2019). Trends in maternal mortality: 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Geneva: World Health Organization; 2019. In *WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division*.

BAB V

STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA RISET DALAM KEBIDANAN

A. Pendahuluan

Budaya riset dalam kebidanan merupakan fondasi penting dalam penguatan praktik profesional yang berbasis evidence. Namun demikian, keberadaan budaya riset tidak terbentuk secara otomatis, melainkan memerlukan proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kesenjangan antara idealitas budaya riset dengan realitas di lapangan, khususnya pada pelayanan kebidanan di tingkat fasilitas kesehatan primer maupun komunitas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dalam praktik kebidanan seringkali disebabkan oleh keterbatasan kompetensi penelitian, kurangnya akses terhadap sumber informasi ilmiah, serta minimnya dukungan institusional. Selain itu, beban kerja bidan yang tinggi dalam pelayanan klinis juga menjadi salah satu faktor yang menghambat keterlibatan aktif dalam kegiatan penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya membangun budaya riset tidak cukup hanya dengan meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memerlukan intervensi pada tingkat institusi dan sistem.

Dalam pelayanan maternal dan neonatal, kebutuhan akan budaya riset menjadi semakin mendesak. Kompleksitas permasalahan kesehatan ibu dan bayi, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis tetapi juga faktor sosial, budaya, dan ekonomi, menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Oleh karena itu, strategi pembangunan budaya riset dalam kebidanan harus mampu mengakomodasi berbagai dimensi tersebut, termasuk integrasi kearifan lokal yang relevan dengan karakteristik masyarakat.

Strategi membangun budaya riset dalam kebidanan pada dasarnya merupakan suatu upaya transformasi, baik pada tingkat individu, organisasi, maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Pada tingkat individu, strategi difokuskan pada penguatan kapasitas bidan dalam berpikir kritis, memahami metodologi penelitian, serta mengaplikasikan evidence dalam praktik. Pada tingkat institusi, strategi diarahkan pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian, termasuk penyediaan sumber daya, kebijakan yang mendukung, serta sistem

insentif yang mendorong produktivitas ilmiah. Sementara itu, pada tingkat sistem, strategi mencakup integrasi riset dalam kebijakan kesehatan, penguatan jejaring kolaborasi, serta peningkatan akses terhadap sumber informasi ilmiah.

Lebih lanjut, strategi pembangunan budaya riset juga perlu mempertimbangkan pendekatan kontekstual berbasis masyarakat. Dalam hal ini, hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi kesehatan, termasuk peningkatan cakupan kunjungan neonatal, sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, dukungan keluarga, serta akses pelayanan. Oleh karena itu, strategi budaya riset yang efektif harus mampu mengintegrasikan hasil penelitian dengan kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga intervensi yang dihasilkan tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga dapat diterima dan diimplementasikan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan budaya riset dalam kebidanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan multi-level dan multi-sektor yang terintegrasi. Bab ini akan membahas secara komprehensif berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk membangun dan memperkuat budaya riset dalam kebidanan, mulai dari tingkat individu, institusi, hingga sistem, serta bagaimana strategi tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks pelayanan kebidanan di masyarakat.

Dengan demikian, budaya riset dalam kebidanan bukan sekadar pilihan, melainkan suatu kebutuhan fundamental dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern yang semakin dinamis dan kompleks.

B. Konsep Budaya Riset dalam Kebidanan

Secara konseptual, budaya riset dapat dipahami sebagai suatu sistem nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas profesional yang mendorong individu maupun kelompok untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan ilmiah. Budaya ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penelitian dalam arti sempit, tetapi juga mencerminkan cara berpikir, sikap, serta orientasi individu terhadap ilmu pengetahuan dan penggunaan bukti dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, budaya riset menjadi indikator penting sejauh mana suatu profesi telah menginternalisasi prinsip-prinsip ilmiah dalam menjalankan perannya (Chalmers R, 2025).

Dalam kebidanan, budaya riset memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Budaya ini mencerminkan sejauh mana penelitian dan penggunaan evidence menjadi bagian integral dari kehidupan profesional bidan. Bidan yang berada dalam lingkungan dengan budaya riset yang kuat akan terbiasa untuk mempertanyakan praktik yang

ada, mencari bukti ilmiah yang relevan, serta mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan klinis. Hal ini menunjukkan bahwa budaya riset bukan sekadar aktivitas tambahan, tetapi merupakan bagian dari proses berpikir profesional yang terus berkembang (Alsaqqa HH, 2024).

Dalam perspektif yang lebih operasional, budaya riset dalam kebidanan dapat dimaknai melalui beberapa dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah adanya kebiasaan melakukan inquiry ilmiah. Inquiry ilmiah merupakan proses sistematis yang melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan penelitian, serta mencari jawaban melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur. Dalam praktik kebidanan, kemampuan ini sangat penting karena banyak permasalahan kesehatan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan rutin atau prosedural. Bidan yang memiliki budaya riset akan lebih peka terhadap permasalahan di lapangan, mampu menggali akar masalah, serta mencari solusi yang berbasis data dan bukti (Byrne ZS, 2025).

Dimensi kedua adalah kemampuan dalam menggunakan evidence dalam praktik. Budaya riset menuntut agar setiap keputusan klinis didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, bukan semata-mata pada pengalaman pribadi atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Dalam hal ini, bidan perlu memiliki kemampuan untuk mengakses sumber informasi ilmiah, seperti jurnal penelitian, pedoman klinis, dan hasil studi terkini. Selain itu, bidan juga harus mampu membaca secara kritis, menilai kualitas penelitian, serta menginterpretasikan hasilnya agar dapat diterapkan secara tepat dalam praktik pelayanan. Integrasi evidence dalam praktik ini menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keamanan pelayanan kebidanan.

Dimensi ketiga adalah komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Budaya riset tidak hanya menempatkan bidan sebagai pengguna ilmu, tetapi juga sebagai kontributor dalam pengembangan ilmu kebidanan. Komitmen ini tercermin dalam keterlibatan aktif dalam kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta partisipasi dalam forum ilmiah seperti seminar dan konferensi. Melalui keterlibatan tersebut, bidan dapat berbagi pengalaman, memperluas wawasan, serta berkontribusi dalam pengembangan praktik kebidanan yang lebih baik. Selain itu, aktivitas ilmiah ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas profesional dan memperkuat identitas keilmuan dalam profesi kebidanan.

Lebih lanjut, budaya riset juga memiliki implikasi yang luas terhadap profesionalisme bidan. Dalam konteks ini, budaya riset menjadi salah satu indikator penting yang membedakan profesi dengan pekerjaan teknis. Profesi ditandai oleh adanya landasan ilmiah yang kuat, otonomi dalam praktik, serta komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kebidanan sebagai profesi kesehatan harus

mampu memenuhi karakteristik tersebut agar dapat diakui sebagai profesi yang mandiri dan kompeten.

Profesi kebidanan yang kuat adalah profesi yang berbasis ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tersebut berkembang melalui penelitian yang berkelanjutan. Tanpa adanya budaya riset, praktik kebidanan akan cenderung stagnan dan tidak mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, dengan budaya riset yang kuat, kebidanan dapat berkembang secara dinamis, adaptif, dan inovatif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat (Pedersen MRV, 2024).

Dengan demikian, budaya riset merupakan bagian integral dari identitas profesional bidan. Budaya ini tidak hanya memperkuat kualitas praktik klinis, tetapi juga meningkatkan kredibilitas profesi, memperluas kontribusi kebidanan dalam sistem kesehatan, serta mendorong terciptanya pelayanan yang lebih efektif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, penguatan budaya riset akan menjadi investasi penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi serta memperkuat sistem pelayanan kebidanan secara keseluruhan.

C. Karakteristik Budaya Riset

Budaya riset dalam kebidanan memiliki sejumlah karakteristik yang dapat diamati baik pada tingkat individu maupun institusi. Karakteristik ini menjadi indikator sejauh mana budaya riset telah terinternalisasi dalam praktik kebidanan (Bernardes A, 2020).

1. Berpikir Kritis

Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan rasional sebelum mengambil keputusan. Dalam kebidanan, berpikir kritis memungkinkan bidan untuk mengevaluasi praktik yang ada, mengidentifikasi potensi risiko, serta memilih intervensi yang paling tepat berdasarkan evidence.

Bidan yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi, tetapi selalu mempertanyakan validitas dan relevansi informasi tersebut. Hal ini sangat penting dalam mencegah praktik yang tidak berbasis bukti atau bahkan berpotensi membahayakan pasien.

2. Berbasis Data

Karakteristik kedua adalah penggunaan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Budaya riset mendorong bidan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data dalam praktik pelayanan. Data dapat berasal dari hasil penelitian, rekam medis, maupun hasil evaluasi program kesehatan.

Pendekatan berbasis data memungkinkan pelayanan kebidanan menjadi lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, penggunaan data juga penting dalam proses monitoring dan evaluasi pelayanan.

3. Inovatif

Budaya riset mendorong munculnya inovasi dalam praktik kebidanan. Inovasi ini dapat berupa pengembangan metode pelayanan baru, pendekatan edukasi yang lebih efektif, maupun integrasi teknologi dalam pelayanan kesehatan.

Inovasi berbasis riset memiliki keunggulan karena didasarkan pada bukti ilmiah, sehingga memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan inovasi yang tidak berbasis evidence.

4. Kolaboratif

Penelitian pada umumnya tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas disiplin. Oleh karena itu, budaya riset juga ditandai dengan adanya kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan lain, akademisi, maupun masyarakat.

Kolaborasi ini penting dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kebidanan, kolaborasi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan interprofesional.

D. Posisi Budaya Riset dalam Kebidanan

Budaya riset memiliki posisi yang sangat strategis dalam kebidanan karena menjadi fondasi utama dalam berbagai aspek praktik profesional. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, kebidanan tidak lagi hanya dipandang sebagai praktik berbasis keterampilan teknis, tetapi sebagai profesi ilmiah yang menuntut pengambilan keputusan berbasis bukti. Oleh karena itu, keberadaan budaya riset menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa setiap tindakan kebidanan yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Salah satu peran utama budaya riset adalah sebagai dasar dalam penerapan Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP). EBMP merupakan pendekatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktik kebidanan, pendekatan ini sangat penting untuk menjamin bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga aman dan sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Dengan adanya budaya riset yang kuat, bidan akan terbiasa untuk mencari,

mengevaluasi, dan menggunakan bukti ilmiah dalam setiap tindakan, sehingga risiko kesalahan klinis dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan.

Selain itu, budaya riset juga berperan penting dalam pengembangan intervensi kesehatan yang inovatif dan kontekstual. Permasalahan kesehatan maternal dan neonatal yang kompleks tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan konvensional, melainkan memerlukan inovasi yang berbasis penelitian. Faktor-faktor seperti kondisi sosial budaya, tingkat pendidikan, akses layanan, serta dukungan keluarga memengaruhi keberhasilan intervensi kesehatan. Oleh karena itu, melalui penelitian, bidan dapat mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan mengembangkan intervensi yang lebih tepat sasaran. Budaya riset memungkinkan bidan untuk tidak hanya mengadopsi intervensi yang sudah ada, tetapi juga menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Lebih lanjut, budaya riset berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan mutu pelayanan kebidanan. Melalui kegiatan penelitian, pengumpulan data, serta evaluasi berbasis evidence, bidan dapat menilai efektivitas pelayanan yang telah diberikan. Proses ini menjadi bagian dari continuous quality improvement, yaitu upaya perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dengan adanya budaya riset, evaluasi tidak lagi bersifat subjektif, tetapi didasarkan pada data yang terukur dan dapat dianalisis secara sistematis. Hal ini memungkinkan terjadinya perbaikan pelayanan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Budaya riset juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sistem kesehatan secara lebih luas. Dalam hal ini, budaya riset berkontribusi dalam (Moreno-Domínguez MJ, 2024):

1. Mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence

Kebijakan kesehatan yang efektif harus didasarkan pada data dan bukti ilmiah yang valid. Budaya riset memungkinkan hasil penelitian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berdampak luas.

2. Meningkatkan daya saing profesi kebidanan

Dalam era globalisasi, profesi kebidanan dituntut untuk mampu bersaing secara internasional. Budaya riset mendorong peningkatan kapasitas ilmiah bidan, termasuk dalam publikasi dan inovasi, sehingga meningkatkan kredibilitas dan daya saing profesi di tingkat global.

3. Memperkuat posisi kebidanan sebagai profesi ilmiah

Profesi yang kuat adalah profesi yang memiliki dasar ilmiah yang kokoh. Melalui budaya riset, kebidanan tidak hanya dipandang sebagai praktik teknis, tetapi sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang melalui penelitian dan inovasi.

Hal ini akan memperkuat posisi kebidanan dalam sistem kesehatan dan meningkatkan pengakuan profesional.

Dengan demikian, budaya riset bukan sekadar elemen tambahan dalam praktik kebidanan, melainkan merupakan inti dari profesionalisme yang modern dan berkualitas. Budaya riset menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan dan praktik, sehingga pelayanan kebidanan dapat dilakukan secara lebih efektif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, penguatan budaya riset akan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi serta penguatan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Li M, Wang W, et.al., 2024).

E. Urgensi Budaya Riset Dalam Pelayanan Kebidanan

Permasalahan kesehatan maternal dan neonatal hingga saat ini masih menjadi tantangan global, terutama di negara berkembang. Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) mencerminkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya optimal. Berbagai faktor yang memengaruhi kondisi ini tidak hanya bersifat medis, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Kompleksitas ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah.

Budaya riset menjadi elemen yang sangat penting dalam pelayanan kebidanan. Budaya riset memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk tidak hanya menjalankan praktik berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi juga berdasarkan hasil penelitian yang valid dan relevan. Dengan adanya budaya riset, setiap intervensi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga meningkatkan keamanan dan efektivitas pelayanan (Almutairi RL, 2022).

Lebih lanjut, budaya riset berperan dalam proses identifikasi masalah secara sistematis. Dalam praktik kebidanan, banyak permasalahan yang seringkali dianggap sebagai hal yang "biasa" atau "lumrah", padahal sebenarnya memerlukan perhatian khusus. Melalui pendekatan riset, bidan dapat menggali akar permasalahan secara lebih mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi, serta merancang solusi yang tepat sasaran. Hal ini sangat penting, terutama dalam menangani masalah kesehatan maternal dan neonatal yang memiliki karakteristik kompleks dan kontekstual.

Selain itu, budaya riset juga mendorong pengembangan intervensi berbasis evidence (evidence-based practice). Intervensi yang dikembangkan melalui penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat, sehingga lebih efektif dibandingkan dengan intervensi yang hanya didasarkan pada asumsi atau pengalaman. Dalam pelayanan kebidanan, penggunaan evidence sangat penting untuk memastikan

bahwa setiap tindakan yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi ibu dan bayi.

Budaya riset juga memiliki peran strategis dalam evaluasi pelayanan. Melalui penelitian dan pengumpulan data, bidan dapat menilai apakah intervensi yang dilakukan telah memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih terdapat kesenjangan antara *evidence* yang tersedia dengan implementasinya. Banyak bidan yang belum terbiasa mengakses, membaca, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Selain itu, keterbatasan waktu, beban kerja yang tinggi, serta minimnya akses terhadap sumber informasi ilmiah juga menjadi hambatan dalam penerapan budaya riset. Akibatnya, praktik kebidanan masih sering didasarkan pada pengalaman subjektif yang belum tentu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penguatan budaya riset bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Tanpa adanya budaya riset, upaya peningkatan kualitas pelayanan akan berjalan lambat dan tidak terarah. Sebaliknya, dengan budaya riset yang kuat, pelayanan kebidanan dapat berkembang secara dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam hal yang lebih spesifik, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor sosial budaya dan dukungan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kesehatan ibu, termasuk dalam pemanfaatan layanan kebidanan seperti kunjungan neonatal. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis riset sangat penting untuk memahami konteks lokal dan merancang intervensi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Dengan demikian, urgensi budaya riset dalam pelayanan kebidanan tidak hanya terletak pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga pada kemampuan untuk menjawab tantangan kesehatan yang kompleks dan dinamis. Budaya riset menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan praktik, sehingga pelayanan kebidanan dapat dilakukan secara lebih profesional, efektif, dan berkelanjutan.

F. Strategi Membangun Budaya Riset dalam Kebidanan

Pembangunan budaya riset dalam kebidanan merupakan suatu proses transformasi yang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Budaya riset bukan hanya sekadar aktivitas penelitian, tetapi mencerminkan pola pikir ilmiah yang terintegrasi dalam praktik pelayanan sehari-hari. Oleh karena itu, strategi yang

dikembangkan harus mampu menjangkau berbagai dimensi, mulai dari individu sebagai pelaku utama, institusi sebagai lingkungan kerja, hingga sistem kesehatan sebagai kerangka kebijakan yang lebih luas (Van Huy N, at. al., 2020).

Pendekatan multi-level menjadi penting karena setiap level memiliki peran dan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi. Kegagalan dalam salah satu level dapat menghambat keberhasilan pembangunan budaya riset secara keseluruhan. Dengan demikian, strategi yang dirancang harus bersifat holistik dan terintegrasi (Van Huy N, at.al., 2020).

1. Strategi pada Level Individu

Pada level individu, fokus utama strategi adalah penguatan kapasitas bidan sebagai pelaku utama pelayanan kebidanan. Individu merupakan titik awal dalam pembentukan budaya riset, karena perubahan pola pikir dan perilaku dimulai dari tingkat personal.

Salah satu aspek yang sangat penting adalah penguatan literasi ilmiah. Literasi ilmiah mencakup kemampuan untuk mengakses, membaca, memahami, serta mengevaluasi literatur ilmiah secara kritis. Dalam praktik kebidanan, kemampuan ini memungkinkan bidan untuk memahami perkembangan ilmu terkini dan menerapkannya dalam pelayanan. Tanpa literasi ilmiah yang memadai, bidan akan kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak, sehingga berisiko menggunakan praktik yang tidak berbasis bukti.

Selain itu, peningkatan kemampuan penelitian terapan menjadi strategi penting dalam membangun budaya riset. Penelitian terapan memungkinkan bidan untuk mengidentifikasi masalah nyata di lapangan dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Bentuk penelitian ini dapat berupa studi kasus, audit klinis, maupun penelitian tindakan (action research) yang berfokus pada perbaikan praktik pelayanan.

Lebih lanjut, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif juga menjadi komponen penting. Berpikir kritis memungkinkan bidan untuk menganalisis informasi secara rasional sebelum mengambil keputusan, sedangkan refleksi praktik membantu dalam mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Dengan kemampuan ini, bidan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Tidak kalah penting, motivasi dan komitmen profesional harus terus ditingkatkan. Budaya riset tidak akan berkembang tanpa adanya dorongan intrinsik dari individu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran bahwa penelitian merupakan bagian dari tanggung jawab profesional bidan.

2. Strategi pada Level Institusi

Institusi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya budaya riset. Tanpa dukungan institusi, upaya yang dilakukan pada level individu akan sulit untuk berkembang secara optimal.

Salah satu strategi utama adalah pengembangan kebijakan berbasis evidence. Institusi perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur pelayanan didasarkan pada bukti ilmiah yang terkini. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) berbasis evidence serta penggunaan clinical guideline dalam praktik pelayanan kebidanan.

Selain itu, penyediaan fasilitas dan sumber daya penelitian menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Institusi harus menyediakan akses terhadap jurnal ilmiah, perpustakaan digital, serta sistem informasi kesehatan yang memadai. Tanpa akses terhadap sumber informasi, bidan akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan dan melakukan penelitian.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah program pelatihan dan mentoring. Pelatihan metodologi penelitian, penulisan ilmiah, serta workshop critical appraisal perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, program mentoring dapat membantu bidan dalam merancang dan melaksanakan penelitian, serta meningkatkan kualitas publikasi ilmiah.

Untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan riset, institusi juga perlu mengembangkan sistem insentif dan penghargaan. Insentif dapat berupa dukungan dana penelitian, penghargaan publikasi, maupun pengakuan profesional. Sistem ini dapat meningkatkan motivasi tenaga kesehatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan penelitian.

3. Strategi pada Level Sistem

Pada level sistem, strategi difokuskan pada penguatan kebijakan dan struktur yang mendukung budaya riset dalam skala yang lebih luas. Sistem kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan budaya riset.

Salah satu strategi utama adalah integrasi riset dalam kebijakan kesehatan. Pengambilan keputusan dalam sistem kesehatan harus didasarkan pada evidence yang kuat. Oleh karena itu, hasil penelitian harus digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan, termasuk dalam pelayanan maternal dan neonatal.

Selanjutnya, penguatan jejaring kolaborasi menjadi strategi yang sangat penting. Kolaborasi antara institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemerintah dapat meningkatkan kualitas penelitian serta mempercepat implementasi hasil penelitian ke dalam praktik. Kolaborasi ini juga

memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar tenaga kesehatan.

Selain itu, peningkatan akses terhadap informasi ilmiah harus menjadi prioritas. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki akses yang memadai terhadap jurnal ilmiah, baik melalui platform nasional maupun internasional. Pengembangan sistem digital kesehatan juga dapat mendukung akses informasi secara lebih luas dan cepat.

4. Integrasi Strategi dalam Lokal

Selain pendekatan multi-level, strategi pembangunan budaya riset juga harus mempertimbangkan konteks lokal. Dalam praktik kebidanan, faktor sosial budaya dan dukungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kesehatan masyarakat.

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya dan komunitas lebih efektif dalam meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan. Oleh karena itu, strategi pembangunan budaya riset harus mampu mengintegrasikan hasil penelitian dengan kearifan lokal, sehingga intervensi yang dilakukan lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat (Br Ginting Munthe N, 2024).

G. Penutup

Budaya riset dalam kebidanan merupakan fondasi utama dalam membangun praktik pelayanan yang profesional, berkualitas, dan berbasis evidence. Melalui budaya riset, bidan tidak hanya berperan sebagai pelaksana pelayanan klinis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta konteks sosial budaya dalam praktik kebidanan sehari-hari. Hal ini menjadi sangat penting dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kesehatan maternal dan neonatal yang semakin dinamis.

Penguatan budaya riset tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendekatan multi-level yang melibatkan individu, institusi, dan sistem kesehatan menjadi kunci dalam membangun ekosistem riset yang kondusif. Pada tingkat individu, diperlukan penguatan kapasitas bidan melalui peningkatan literasi ilmiah, kemampuan penelitian, serta pengembangan pola pikir kritis dan reflektif. Pada tingkat institusi, dukungan kebijakan, fasilitas, pelatihan, serta sistem insentif menjadi faktor penting dalam mendorong keterlibatan aktif tenaga kesehatan dalam kegiatan penelitian. Sementara itu, pada tingkat sistem, integrasi riset dalam kebijakan kesehatan, penguatan jejaring kolaborasi, serta peningkatan akses

terhadap informasi ilmiah menjadi elemen strategis dalam menciptakan budaya riset yang berkelanjutan (Tenny S, 2022).

Selain itu, integrasi pendekatan berbasis kearifan lokal juga menjadi aspek penting dalam pengembangan budaya riset kebidanan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial budaya dan dukungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, budaya riset yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal, sehingga intervensi yang dihasilkan tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

Dengan demikian, budaya riset bukan sekadar aktivitas tambahan dalam praktik kebidanan, melainkan merupakan inti dari profesionalisme yang modern dan berorientasi pada mutu. Budaya riset menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan praktik, serta menjadi dasar dalam pengembangan inovasi pelayanan kebidanan yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penguatan budaya riset diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, menurunkan angka kematian maternal dan neonatal, serta memperkuat posisi kebidanan sebagai profesi ilmiah yang unggul dan kompetitif.

Referensi

- Almutairi RL, Aditya RS, Kodriyah L, Yusuf A, Solikhah FK, Al Razeeni DM, Kotijah S. Analysis of organizational culture factors that influence the performance of health care professionals: A literature review. *J Public Health Afr.* 2022 Dec 07;13(Suppl 2):2415.
- Alsaqqa HH. Organizational Culture Relation With Innovation Comment on "Employee-Driven Innovation in Health Organizations: Insights From a Scoping Review". *Int J Health Policy Manag.* 2024;13: 8583.
- Bernardes A, Gabriel CS, Cummings GG, Zanetti ACB, Leoneti AB, Caldana G, Maziero VG. Organizational culture, authentic leadership and quality improvement in Canadian healthcare facilities. *Rev Bras Enferm.* 2020;73Suppl 5(Suppl 5):e20190732.
- Br Ginting Munthe N, Machmud R, Semiarty R, Serudji J, Bachtiar A, Yani FF, Symond D and Nelwati N. Determinant of Neonatal Visit Coverage Rate in Serdang Bedagai Regency North Sumatra Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (JIKM)* 2024; 15(3): 401–413.
- Byrne ZS, Cave KA, Raymer SD. Using a Generalizable Photo-Coding Methodology for Assessing Organizational Culture Artifacts. *J Bus Psychol.* 2022;37(4):797-811.
- Chalmers R, Marras A, Brannan GD. Organizational Culture. 2025 Feb 17. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan–. PMID: 32809378.
- Li M, Wang W, Zhang J, Zhao R, Loban K, Yang H, Mitchell R. Organizational culture and turnover intention among primary care providers: a multilevel study in four large cities in China. *Glob Health Action.* 2024 Dec 31;17(1):2346203.
- Moreno-Domínguez MJ, Escobar-Rodríguez T, Pelayo-Díaz YM, Tovar-García I. Organizational culture and leadership style in Spanish Hospitals: Effects on knowledge management and efficiency. *Heliyon.* 2024 Oct 30;10(20): e39216.
- Pedersen MRV, Kusk MW, Lysdahlgaard S, Mork-Knudsen H, Malamateniou C, Jensen J. A Nordic survey on artificial intelligence in the radiography profession - Is the profession ready for a culture change? *Radiography (Lond).* 2024 Jul;30(4):1106-1115.
- Tenny S, Brannan JM, Brannan GD. Qualitative Study. 2022 Sep 18. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan–. PMID: 29262162.
- Van Huy N, Thu NTH, Anh NLT, Au NTH, Phuong NT, Cham NT, Minh PD. The validation

of organisational culture assessment instrument in healthcare setting: results from a cross-sectional study in Vietnam. BMC Public Health. 2020 Mar 12;20(1):316.

PROFIL PENULIS



Dr. Yeni Fitrianiingsih, SST., MKes. Lahir di Kuningan, 12 Desember 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma 4 Pada Program Studi D4 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Sain Terapan UNDIP lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi DIKK (Doktoral Ilmu Kedokteran Kesehatan), Universitas Diponegoro (UNDIP) lulus tahun 2022.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1989 bekerja sebagai perawat di RS tahun 1990 – 2010 bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Kab Sukabumi dan Kota Cirebon Jawa Barat serta Paramedis Teladan Tingkat

Jawa Barat Tahun 1997. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus dan bayi, Praktik Kebidanan Komunitas, Asuhan Kebidanan Holistik, Etika Hukum kesehatan dan Midwifery Entrepreneurship. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu mengajar, melakukan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat, sebagai penulis buku, publikasi ilmiah jurnal nasional/Internasional terakreditasi, Narasumber seminar dan sebagai Ketua IBI Kota Cirebon (Periode tahun 2018-2023), Sebagai Surveyor KAKP Akreditasi Puskesmas dan Klinik, Reviuwer Penelitian Jurnal Internasional dan nasional, , Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yfitrianiingsih44@gmail.com

Motto: **"Menuntut ilmu adalah investasi terbaik, karena ilmu yang bermanfaat akan menjadi cahaya di dunia dan pembela di akhirat."**



Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb. Lahir di Sukoharjo, 17 Agustus 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D IV pada Program Studi Kebidanan, Universitas Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun 2011, kemudian mengambil Pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai Dosen Tetap di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saat ini penulis bekerja di Universitas Kusuma Husada

Surakarta mengampu mata kuliah Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hutaripujiastuti877@gmail.com

Motto: "Sabar meringankan, syukur menambahkan, zikir menenangkan, dan doa menguatkan"



Bdn. Sarah Fitria, M.Tr.Keb. Lahir di Padang Panjang, 02 Agustus 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2019. Kemudian lanjut Pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Payung Negeri dan lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 – sekarang sebagai Dosen

Tetap di Universitas Muhammadiyah Riau. Saat ini penulis bekerja di STIKes INDONESIA mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sarahfitria@umri.ac.id

Motto: "Menjadi bermanfaat adalah tujuan utama dari setiap ilmu yang dimiliki."



Bdn. Maesaroh, S.ST., M.Kes. Lahir di Subang, 30 November 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Bidan Pendidik, Poltekkes Bhakti Pertiwi Husada Cirebon Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Bangsa pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail

maesarohnayla77@gmail.com



Dr. Bd. Novita Br Ginting Munthe, SST., M.Keb., lahir di Kabanjahe pada tanggal 28 November 1989. Penulis merupakan akademisi dan praktisi di bidang kebidanan yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan ilmu kebidanan berbasis evidence. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Program Diploma III Kebidanan di STIKes Santa Elisabeth Medan yang diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Universitas Sumatera Utara pada periode 2011–2012. Ketertarikan terhadap pengembangan ilmu kebidanan mendorong penulis untuk

melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013 – 2015.

Untuk memperkuat kompetensi profesional, penulis juga menempuh Pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Deli Husada Delitua pada periode 2019 – 2020. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan doktoral di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2025.

Sejak tahun 2012, penulis telah aktif sebagai tenaga pengajar di bidang kebidanan dan saat ini mengabdikan diri sebagai dosen di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis terlibat aktif dalam berbagai kegiatan akademik, antara lain penulisan buku ajar kebidanan, penyusunan soal uji kompetensi bidan, serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional.

Selain itu, penulis memiliki minat penelitian pada bidang kesehatan maternal dan neonatal, khususnya terkait pengembangan model pelayanan kebidanan berbasis kearifan lokal dan evidence-based practice.

Penulis dapat dihubungi melalui email:

✉ novitagintingmunthe89@gmail.com

Pesan untuk pembaca:

Do the best, leave the bad.

Motto: "Syukur menjadikan hati tenang, sabar menjadikan langkah kuat"

Sinopsis

Buku Referensi Evidence-Based Midwifery Practice dalam Pelayanan Maternal dan Neonatal membahas konsep dan penerapan praktik kebidanan berbasis bukti dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Buku ini menjelaskan pentingnya penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan keputusan klinis agar asuhan kebidanan yang diberikan lebih aman, efektif, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pembahasan dalam buku ini mencakup prinsip dasar evidence-based practice, tahapan penerapannya dalam praktik kebidanan, pencarian dan penilaian bukti ilmiah, serta penerapan bukti dalam pelayanan maternal dan neonatal. Buku ini juga menekankan peran bidan dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, mencegah komplikasi, memberikan edukasi kesehatan, serta mendukung pelayanan yang berpusat pada perempuan, bayi, dan keluarga.

Dengan penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, peneliti, dan tenaga kesehatan lainnya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan bidan dalam menerapkan asuhan kebidanan yang profesional, humanis, berbasis bukti, serta berorientasi pada keselamatan dan kualitas pelayanan.

Buku referensi Evidence-Based Midwifery Practice dalam Pelayanan Maternal dan Neonatal membahas konsep dan penerapan praktik kebidanan berbasis bukti dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Buku ini menjelaskan pentingnya penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan keputusan klinis agar asuhan kebidanan yang diberikan lebih aman, efektif, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pembahasan dalam buku ini mencakup prinsip dasar evidence-based practice, tahapan penerapannya dalam praktik kebidanan, pencarian dan penilaian bukti ilmiah, serta penerapan bukti dalam pelayanan maternal dan neonatal. Buku ini juga menekankan peran bidan dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, mencegah komplikasi, memberikan edukasi kesehatan, serta mendukung pelayanan yang berpusat pada perempuan, bayi, dan keluarga.

Dengan penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, peneliti, dan tenaga kesehatan lainnya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan bidan dalam menerapkan asuhan kebidanan yang profesional, humanis, berbasis bukti, serta berorientasi pada keselamatan dan kualitas pelayanan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-28-2 (PDF)



9

786347

756282